卵巢癌中西医结合诊疗指南

编制说明

提出单位：中国中医科学院广安门医院

归口单位：中华中医药学会

主要起草单位：中国中医科学院广安门医院、北京大学人民医院、中国医学科学院肿瘤医院、上海中医药大学附属龙华医院、广东省中医院

顾问：朴炳奎、王建六、花宝金

主要起草人：卢雯平、田小飞、田建辉、白萍、肖静、冯利、许云、岑尧、范秀华、康山、韩凤娟、宋恩峰

本文件主审人：朴炳奎、王建六、花宝金、林丽珠、李斌、侯炜、陈薇、孙长岗、杨英捷、薛冬、张青、李鹤

二〇二三年一月

目次

一、工作简况……3
二、指南编制原则和关键技术内容……3
三、主要工作过程……5
四、与国内外同类指南的对比和最新指南采用情况……58
五、与现行强制性国家标准或政策法规的关系……58
六、代表性分歧意见的处理经过和依据……59
七、宣传、贯彻指南和后效评价指南的要求和措施……59
八、废止现行有关指南的建议……59
九、附录……59

卵巢癌中西医结合诊疗指南编制说明

一、工作简况

1.任务背景

在妇科恶性肿瘤中，卵巢癌的死亡率最高，严重威胁妇女健康。其起病隐匿，70%卵巢癌确诊已属中晚期，上皮癌在卵巢恶性肿瘤中占90%。近年我国开展了众多高水平的循证医学研究，摸索中医药与手术、化疗、靶向治疗等结合的治疗规律。中西医结合治疗卵巢癌在临床中的良好疗效充分说明：两种治疗方法可以互相扬长避短，优势互补，有利于肿瘤患者获益。

由于目前中西医结合治疗卵巢癌的水平参差不齐,迫切需要一部有实际应用价值的中西医结合治疗卵巢癌的指导性文件，最大程度提高临床疗效。故采用现代循证医学原则并结合中医临床特点，编纂指南，供从事中医、西医及中西医结合工作的医师在临床实践中参考使用,对中西医结合诊疗上皮性卵巢癌的临床行为的科学化、规范化、合理化。

2.任务来源

本任务来源于中华中医药学会《卵巢癌中西医结合诊疗指南》制定计划，由中国中医科学院广安门医院负责组织完成。立项时间是 2022 年 8 月。

3.指南起草单位

中国中医科学院广安门医院、北京大学人民医院、中国医学科学院肿瘤医院、上海中医药大学附属龙华医院、广东省中医院、首都医科大学附属北京中医医院、潍坊市中医院、山东中医药大学附属医院、北京中医药大学第三附属医院、北京大学肿瘤医院、首都医科大学附属朝阳医院、内蒙古自治区人民医院、黑龙江中医药大学附属第一医院、河北医科大学第四医院、上海交大附属仁济医院、陕西省肿瘤医院、贵州医科大学附属医院、南京医科大学第二附属医院。

二、指南的编制原则和关键技术内容

1.指南的编制依据和原则

本指南文本撰写依据 GB/T1.1-2020《标准化工作导则第 1 部分：标准的结构和编写》进行。

2.指南的关键技术内容

目　次.....II
前　言.....IV
引　言.....V
卵巢癌中西医结合诊疗指南.....7
1 范围.....7

2 规范性引用文件.....7
3 术语和定义.....7
4 诊断及鉴别诊断.....8
4.1 西医诊断思路.....9
4.1.1 诊断标准.....9
4.1.2 鉴别诊断.....9
4.2 中西医结合诊断思路.....9
5 卵巢癌的西医治疗.....10
5.1 新诊断卵巢癌的西医治疗.....10
5.2 复发后卵巢癌的西医治疗.....11
6 卵巢癌的中医治疗.....11
6.1 围手术期中医治疗.....11
6.1.1 肠梗阻（肠粘连）.....11
6.1.2 伤口不愈合.....15
6.1.3 淋巴囊肿.....16
6.2 化疗及靶向治疗不良反应的中医治疗.....17
6.2.1 骨髓抑制.....18
6.2.2 消化道不良反应.....22
6.2.3 周围神经病变.....25
6.2.4 脱发.....28
6.2.5 高血压.....29
6.2.6 手足皮肤不良反应.....33
6.3 晚期卵巢癌中医维持治疗.....34
7. 其他.....40
7.1 癌因性疲乏的中医治疗.....40
7.2 精神心理的中医治疗.....44
8. 结语.....46
附录 A.....48
（资料性）编制方法.....48
附录 B.....51
（资料性）证据概要表.....51
附录 C.....81
（资料性）缩略词对照表.....81
附录 D.....82
（资料性）手术病理分期.....82

附录 E.....83
（资料性）疗效评价.....83
附录 F.....86
（资料性）PARP 抑制剂奥拉帕利常见的中药及食品禁忌.....86
参 考 文 献.....88

三、主要工作过程

（一）提案、申请、立项

在前期《卵巢癌中西医结合专家共识》的制订基础上，2022 年 7 月指南负责起草单位中国中医科学院广安门医院向中国中医药学会提出《卵巢癌中西医结合诊疗指南》的立项申请。2022 年 8 月 19 日学会经过审查和论证对《卵巢癌中西医结合诊疗指南》完成了学会立项。并在国际实践指南注册与透明化平台进行了注册。

国际实践指南注册与透明化平台
Practice guideline REgistration for transPAREncy (PREPARE)

注册证明

名称：卵巢癌中西医结合诊疗指南
注册号：PREPARE-2022CN467
制订机构：中华中医药学会
通过时间：2022年08月16日

国际实践指南注册平台
2022.08.16

（二）成立指南起草组

1.指南起草组成立方式

起草组由负责人卢雯平教授召集和起草专家推荐结合的方式确定项目组成员，召开专家会议正式成立起草组。

2.指南起草组组成情况

（1）指南起草组组成情况

起草单位中国中医科学院广安门医院为三级甲等中医院。起草组成员涉及中医肿瘤、中西医结合肿瘤、西医肿瘤、妇科等多领域，北京、上海、广东、山东、内蒙古、黑龙江、河北、陕西、贵州、江苏、甘肃等多地区，职称达高级以上的专家。

（2）指南起草组成员名单及分工

以表格形式列出，见表 1。

表 1 指南起草组成员及其工作内容

序号	姓名	单位与科室	学历	职称	工作内容
1	卢雯平	中国中医科学院广安门医院	博士	主任医师	负责人 执笔人
2	朴炳奎	中国中医科学院广安门医院	博士	主任医师	顾问、主审人
3	王建六	北京大学人民医院	博士	主任医师	顾问、主审人
4	花宝金	中国中医科学院广安门医院	博士	主任医师	顾问、主审人
5	李斌	中国医学科学院肿瘤医院	博士	主任医师	负责人、主审人
6	田建辉	上海中医药大学附属龙华医院	博士	主任医师	执笔人
7	肖静	广东省中医院	博士	主任医师	执笔人
8	侯炜	中国中医科学院广安门医院	博士	主任医师	负责人、主审人
9	白萍	中国医学科学院肿瘤医院	博士	主任医师	执笔人
10	岑尧	内蒙古自治区人民医院妇科	硕士	主任医师	执笔人
11	陈薇	北京中医药大学	博士	研究员	主审人
12	林丽珠	广州中医药大学第一附属医院	博士	主任医师	主审人
13	范秀华	中国中医科学院广安门医院	博士	研究员	执笔人
14	冯利	中国医学科学院肿瘤医院中医科	博士	主任医师	执笔人
15	韩凤娟	黑龙江中医药大学附属第一医院妇科	博士	主任医师	执笔人
16	康山	河北医科大学第四医院妇科	博士	主任医师	执笔人
17	李鹤	上海交通大学医学院附属仁济医院	博士	主任医师	主审人
18	宋恩峰	武汉大学人民医院	博士	主任医师	执笔人
19	田小飞	陕西省肿瘤医院妇瘤科	博士	主任医师	执笔人
20	许云	中国中医科学院西苑医院肿瘤科	博士	副主任医师	执笔人
21	薛冬	北京大学肿瘤医院中西医	博士	主任医师	主审人

		结合科			
22	杨英捷	贵州医科大学附属医院妇科	博士	主任医师	主审人
23	孙长岗	潍坊医学院附属医院	博士	主任医师	主审人
24	张青	北京中医医院肿瘤科	博士	主任医师	主审人

3.利益冲突声明

本指南制订工作组、专家组成员均填写了利益声明表，均声明不存在与其工作职责相冲突的任何经济利益或非经济利益以及任何直接或间接的义务和责任。同时本指南推荐的中医药、中成药均无商业利益冲突。

（三）确定指南的题目和范围

依据NICE指南主题选择原则确定指南的题目和范围。

（1） 检索：确定相关已发布指南的概况；相关政策或法律问题；关键的系统评价及流行病学研究；有关临床实践的现状、成本使用、资源消耗、安全性等相关信息；发病、自然病程等统计数据；干预应用的现状及安全性；接受卫生服务的目标人群或其照护者、公众的观点意愿；

（2） 指南构建背景的分析理解，包括：指南构建的理由、疾病负担、疾病对社会经济或公平性方面不同影响、目前的治疗护理现状、照护负担、人力资源和医疗服务组织使用、有关法律和监管、指南使用者的经验和安全性方面；

（3）确定人群和关键议题：包括主要结局指标的部分。

（4）计划新指南如何与NICE路径结合；

（5）对范围草案进行商议；

（6）讨论咨询后确定最终指南范围。

（四）构建指南问题

1.专家访谈

（1）访谈方案确定过程及方法

课题组对中国中医科学院广安门医院、中国中医科学院肿瘤医院擅长诊治卵巢癌具有高级职称的2位专家进行访谈。首先向被访者介绍访谈的背景、目的及意义。访谈在医生休息室进行，时间10-20min，平均约10min。由 2 名访谈员进行，询问并记录专家基本信息，包括姓名、性别、年龄、专业背景等，之后依照拟定的访谈提纲依次向专家咨询。访谈时明确每个问题的核心内容，灵活掌握访谈的提问顺序。访谈内容本指南制定的相关内容。受访专家名单，见表2。

（2）受访专家名单

建议表格的形式列出，见表2。

表 2 专家访谈受访专家名单

姓名	单位	职务/职称	专业
花宝金	中国中医科学院广安门医院	副院长/主任医师	中医肿瘤学
王建六	北京大学人民医院	副院长/主任医师	中医肿瘤学

（3）访谈提纲：

1.您认为中医在卵巢癌治疗中如何参与？2.您认为中医药治疗对患者术后的生存质量有何影响？ 3.您认为中医药治疗对围化疗期患者生存质量有何影响？4.您认为中医药单药或合并西医规范治疗对患者的生存期有何影响？安全性如何？5.您认为中医药治疗还对困扰卵巢癌患者的那些疾病或症状有改善？

（4）访谈结论

1.中医在卵巢癌的手术、化疗、靶向、维持治疗阶段均可参与。

2. 中医药治疗能改善患者术后淋巴囊肿、伤口难愈和腹胀腹痛的症状

3.中医药治疗能改善围化疗期患者的骨髓抑制、脱发和消化道不良反应。

4.中医药维持治疗能提高患者的生存质量，改善PARP抑制剂或TKI引起的不良反应。

5.中医药还能治疗癌因性疲乏和焦虑抑郁。

2.临床调研

（1）调研方案确定的过程及方法

充分了解一线临床医生的实际诊疗情况和诉求，并在此基础上形成的临床问题，可为指南或共识的制定提供方向性指导，使指南更具有临床价值。因此，在《卵巢癌中西医结合诊疗指南》制定中，项目组在全国范围开展临床调研研究，作为形成临床问题的关键步骤之一。

项目组基于国内临床医生面临的实际情况，开展临床调研研究。工作组利用问卷星发放电子问卷 20 份，对一些问题进行了调研，具体见附件一。调研问卷采用半结构化设计，问卷设计应紧密围绕指南的主题。本指南的主题是卵巢癌的中西医结合诊疗，因此临床调研应中西医并重，了解中医和西医的治疗情况，在此基础上重点关注临床医生在治疗卵巢癌时遇到的实际问题，如希望中西医结合的时机、患者对中医药的接受程度、临床用药依据、选择干预措施时考虑的因素、临床诊疗中存在的问题、对指南或共识的建议等。

（2）调研对象分布情况

临床调研涉及11个地区（北京、上海、广东、山东、内蒙古、黑龙江、河北、陕西、贵州、江苏、甘肃），选择地域内有代表性的19家医院进行调研，大多数为三级甲等医院。选择有卵巢癌诊疗经验的中医、中西医结合及西医临床医生进行调研。本研究共调研20名临床医生，其中主任医师14名，副主任医师4名，主治医师2名。

（3）调研结论

1）临床医生的诊疗应基于目前最佳证据，同时结合个人经验及患者意愿进行。
2）在指南或共识内容上，应注重古今医案、医家经验对指南的指导作用。
3）在卵巢癌的手术和化疗阶段，中医改善生存质量，维持治疗阶段，中医能预防复发转移。
4）突出临床实用性。
5）重视证据，但不局限于证据。

6）指南或共识可涉及卵巢癌的中西医诊断、围手术期并发症（伤口不愈合、肠梗阻、淋巴囊肿）中医药管理、围化疗期（消化道反应、骨髓抑制、周围神经损伤、脱发）的中医药管理、维持治疗相关不良反应的中医药管理（PARPi、小分子 TKI）及焦虑、癌因性疲乏中医管理等方面内容。

7）突出辨证要点，突出中医特色疗法。

8）指南发布后注意指南的宣贯和再评价。

3.指南问题原始清单

建议以表格形式列出根据专家访谈及临床调研结果形成的指南问题原始清单，一般包括基础问题和临床问题，基础问题不能按照PICO化原则构建，临床问题需按照PICO化原则构建，详见表3。

表 3 指南原始问题清单

基础问题					
序号	问题				
1	卵巢癌一线维持治疗期分为哪几个证型？				
2	卵巢癌二线维持治疗期分为哪几个证型？				
临床问题					
序号	问题	P（研究对象）	I（干预措施）	C（对照措施）	O（结局指标）
1	对卵巢癌术后患者，中医单用或者联合西医常规治疗对防治术后并发症（腹胀腹痛、伤口难愈、淋囊肿）疗效及安全性如何？	卵巢癌术后患者	中医单用或者联合西医常规治疗	西医常规治疗	疗效和安全性
2	对接受化疗的卵巢癌患者，中医单用或者联合西医常规治疗对化疗不良反应的控制（消化道反应、骨髓抑制、心脏不良反应、脱发）的疗效和安全性如何？	接受化疗的卵巢癌患者	中医单用或者联合西医常规治疗	西医常规治疗	疗效和安全性
3	对于维持治疗期（一线、二线）卵巢癌患者，中医单用或联合西医常规治疗的疗效及安全性如何？	维持治疗期卵巢癌患者	中医单用或者联合西医常规治疗	西医常规治疗	疗效和安全性
4	卵巢癌使用抗血管生成靶向药物引起血压升高，合并与不合并中医药（中药、适宜技术）干预，哪种更有优势？	高血压患者	中医（中药、中医适宜技术）单用或联合西医常规治疗	西医常规治疗	疗效及安全性
5	卵巢癌化疗或靶向治疗期间出现手足皮肤不良反应，中医药（中药、中医适宜技术）	使用化疗或血管生成抑制剂靶向治疗出现手足	中医（中药、中医适宜技术）单用或联合西医常规	西医常规治疗	疗效及安全性

	的疗效及安全性如何？	不良反应的卵巢癌患者	治疗		
6	对卵巢癌患者，中医（中药、中医适宜技术）单用或者联合西医常规干预癌因性疲乏的疗效及安全性如何？	卵巢癌患者	中医（中药、中医适宜技术）单用或联合西医常规治疗	西医常规治疗	疗效及安全性
7	对卵巢癌合并焦虑患者，中医（中药、中医适宜技术）单用或者联合西医常规干预焦虑症状的疗效及安全性如何？	卵巢癌合并焦虑患者	中医（中药、中医适宜技术）单用或联合西医常规治疗	西医常规治疗	疗效及安全性

4.指南问题

（1）指南问题形成方法

工作组通过文献检索和专家访谈征集了初始临床问题，再通过Delphi法征求专家意见，对每个临床问题勾选“重要”“一般”，“不重要”投票，临床问题“重要”比例>60%，我们认为达成共识，形成最终的问题清单。专家共识会议纪要见附录。

（2）指南问题清单

建议以表格形式列出最终的指南问题清单。见表4。

表 4 指南问题清单

基础问题					
序号	**问题**				
1	卵巢癌常见的中医证型及诊断要点？				
临床问题					
序号	**问题**	**P（研究对象）**	**I（干预措施）**	**C（对照措施）**	**O（结局指标）**
1	卵巢癌术后肠梗阻（肠粘连），合并与不合并中医药（中药、适宜技术）干预，哪种更有优势？	卵巢癌术后患者	合并中医药（中药、适宜技术）	西医常规治疗	肛门排气时间、首次排便时间、腹胀持续时间、不良反应
2	卵巢癌术后伤口不愈合，合并与不合并中医药（中药、适宜技术）干预哪种更有优势？	卵巢癌术后患者	合并中医药（中药、适宜技术）	西医常规治疗	伤口愈合时间、不良反应
3	卵巢癌术后淋巴囊肿，合并与不合并中医药（中药、适宜技术）干预，哪种更有优势？	卵巢癌术后患者	合并中医药（中药、适宜技术）	西医常规治疗	有效率、囊肿消退时间、引流管留置时间、盆腔积液量、不良反应
4	卵巢癌化疗、PARPi导致的骨髓抑制，合并与不合并中医	接受化疗的卵巢癌患者	合并中医药（中药、适宜技术）	西医常规治疗	白细胞、红细胞、血红蛋白、血小板、

	药（中药、适宜技术）哪种更有优势？				有效率、不良反应
5	卵巢癌化疗、PARPi导致的消化道不良反应，合并与不合并中医药（中药、适宜技术）哪种更有优势？	接受化疗的卵巢癌患者	合并中医药（中药、适宜技术）	西医常规治疗	恶心、呕吐缓解率、便秘发生率、不良反应
6	卵巢癌化疗导致的周围神经病变，合并与不合并（中药、适宜技术）干预，哪种更有优势？	接受化疗并出现周围神经病变的卵巢癌患者	合并中医药（中药、适宜技术）	西医常规治疗	有效率、不良反应
7	卵巢癌化疗后脱发，合并与不合并中医药（中药、适宜技术）干预，哪种更有优势？	接受化疗的卵巢癌患者	合并中医药（中药、适宜技术）	西医常规治疗	发生率、不良反应
8	卵巢癌使用抗血管生成靶向药物引起血压升高，合并与不合并中医药（中药、适宜技术）干预，哪种更有优势？	血压升高患者	合并中医药（中药、适宜技术）	西医常规治疗	有效率、收缩压、舒张压、不良反应
9	卵巢癌化疗或靶向治疗期间出现手足皮肤不良反应，中医药（中药、中医适宜技术）的疗效及安全性如何？	维持治疗期卵巢癌患者	中医（中药、中医适宜技术）单用或联合西医常规治疗	西医常规治疗	生活质量、不良反应
10	对卵巢癌患者，中医药（中药、适宜技术）单用或者联合西医常规干预癌因性疲乏的疗效及安全性如何？	癌因性疲乏患者	中医（中药、中医适宜技术）单用或联合西医常规治疗	西医常规治疗	Piper疲乏量表评分、改善率、不良反应
11	对卵巢癌合并焦虑患者，中医药（中药、适宜技术）单用或者联合西医常规干预焦虑症状的疗效及安全性如何？	焦虑症状的卵巢癌患者	合并中医药（中药、适宜技术）	西医常规治疗	焦虑自评量表、汉密尔顿焦虑量表、不良反应
12	抗肿瘤治疗期间出现手足不良反应的卵巢癌患者，中医药（中药、中医适宜技术）的疗效及安全性如何？	出现手足不良反应的卵巢癌患者	中医（中药、中医适宜技术）单用或联合西医常规治疗	西医常规治疗	有效率、不良反应

（五）证据的检索、筛选、提取与综合

1.证据检索

（1）检索方法

文献检索范围为中国知网（CNKI）、中国生物医学文献数据库(CBM)、万方数据库（Wan fang）、维普数据库（VIP）、Pubmed、Embase、The Cochrane Library，收集自建库至2022年5月中医药干预卵巢癌患者的Meta分析、系统评价、随机对照试验等，检索策略参照中华中医药学会《中医药整体证据研究的标准化操作规程》（2020年3月版）。文献语种为中文和英文。采取主题词和自由词相结合的方式检索，检索词根据不同的问题设置。

根据每个问题的P、I、C、O或关键词单独进行检索。

①中文数据库检索式（以肠梗阻（肠粘连）为例）

(SU='卵巢癌' OR SU='卵巢恶性肿瘤' OR SU='卵巢肿瘤' OR SU='癥瘕' OR SU '积聚' OR SU='肠蕈' OR SU='石瘕' OR SU='妇科肿瘤' OR SU='妇科恶性肿瘤' OR SU='腹腔镜' OR SU='分期' OR SU='盆腔淋巴清扫' OR SU='盆腔淋巴结清扫' OR SU='减瘤' OR SU='肿瘤细胞减灭') AND (TKA='术后' OR TKA='手术') AND (TKA='腹胀' OR TKA='腹痛' OR TKA='肠胀气' OR TKA='肠梗阻' OR TKA='肠麻痹' OR TKA='肠粘连' OR TKA='胃肠功能' OR TKA='肠道积气' OR TKA='胃肠蠕动' OR TKA='应激性溃疡' OR TKA='排气' OR TKA='排便' OR TKA='肠瘫' OR TKA='肠鸣') AND (TKA= '中医' OR TKA= '中西医' OR TKA= '中医疗法' OR TKA= '辨病论治' OR TKA= '辨证' OR TKA= '辨证论治' OR TKA= '辨症施治' OR TKA= '汉方' OR TKA= '祖国医学' OR TKA= '传统医学' OR TKA= '传统治疗' OR TKA= '替代治疗' OR TKA= '中国传统医学' OR TKA= '民族医学' OR TKA= '草药' OR TKA= '中草药' OR TKA= '中药' OR TKA= '中药疗法' OR TKA= '中成药'TKA= '中西药' OR TKA= '传统医药' OR TKA= '植物药' OR TKA= '中药治法' OR TKA= '熏洗' OR TKA= '药浴' OR TKA= '沐足' OR TKA= '足浴' OR TKA= '灌肠' OR TKA= '熨法' OR TKA= '药熨' OR TKA= '热熨' OR TKA= '热敷' OR TKA= '敷脐' OR TKA='脐灸' OR TKA= '药枕' OR TKA= '药烘' OR TKA= '针刺' OR TKA= '灸' OR TKA= '针法' OR TKA= '刺法' OR TKA= '体针' OR TKA= '腹针' OR TKA= '温针' OR TKA= '火针' OR TKA= '电针' OR TKA= '电磁针' OR TKA= '梅花针' OR TKA= '水针' OR TKA= '穴位注射' OR TKA= '经络注射' OR TKA= '穴位按压' OR TKA= '穴位按摩' OR TKA= '指压穴位' OR TKA= '耳压' OR TKA= '耳针' OR TKA= '耳穴' OR TKA= '耳豆' OR TKA= '埋藏疗法' OR TKA= '埋线' OR TKA= '外治' OR TKA= '推拿' OR TKA= '按摩' OR TKA= '拔罐' OR TKA= '药罐' OR TKA= '推罐' OR TKA= '闪罐' OR TKA= '电罐' OR TKA= '火罐' OR TKA= '砭石' OR TKA= '砭术' OR TKA= '砭法' OR TKA= '刮痧' OR TKA= '刮搓' OR TKA= '挑治' OR TKA= '割治' OR TKA= '发泡' OR TKA= '导引' OR TKA= '吐纳' OR TKA= '气功' OR TKA= '太极' OR TKA= '八段锦' OR TKA= '刺络' OR TKA= '刺血' OR TKA= '放血' OR TKA= '三棱针' OR TKA='热奄包') AND (TKA = '系统综述' OR TKA = 'meta' OR TKA = '荟萃分析' OR TKA = '系统分析' OR TKA = '临床观察' OR TKA = '临床评估' OR TKA = '临床试验' OR TKA = '临床效果' OR TKA = '临床研究' OR TKA = '疗效' OR TKA = '评价研究' OR TKA = '前瞻性' OR TKA = '随访' OR TKA = '对比研究' OR TKA = '多中心' OR TKA = '随机' OR TKA = '对照' OR TKA = '病例报告' OR TKA = '病例研究' OR TKA = '病例分析' OR TKA = '病例报道')

②英文数据库检索式

((((((((traditional chinese medicine) OR (traditional medicine)) OR (chinese traditional)) OR (chinese herbal drug)) OR (acupuncture)) OR (moxibustion)) OR (external therapy))) AND ((((((randomized controlled trial) OR (randomized)) OR (drug therapy)) OR (randomly)) OR (trial)) OR (meta))) AND (((Abdomen[MeSH Terms])) OR (Abdomens[Title/Abstract]))) AND ((((((((((ovarian neoplasms[MeSH Terms]) OR (Neoplasm, Ovarian[Title/Abstract])) OR (Ovarian

Neoplasm*[Title/Abstract])) OR (Neoplasm*, Ovary[Title/Abstract])) OR (Ovary Neoplasm[Title/Abstract])) OR (Neoplasms, Ovarian[Title/Abstract])) OR (Ovary Cancer*[Title/Abstract])) OR (Cancer*, Ovary[Title/Abstract])) OR (Ovarian Cancer*[Title/Abstract])) OR (Cancer*, Ovarian[Title/Abstract])) OR (Cancer of Ovary[Title/Abstract])) OR (Cancer of the Ovary[Title/Abstract]))

Translations

("medicine, chinese traditional"[MeSH Terms] OR ("medicine"[All Fields] AND "chinese"[All Fields] AND "traditional"[All Fields]) OR "chinese traditional medicine"[All Fields] OR ("traditional"[All Fields] AND "chinese"[All Fields] AND "medicine"[All Fields]) OR "traditional chinese medicine"[All Fields] OR ("medicine, traditional"[MeSH Terms] OR ("medicine"[All Fields] AND "traditional"[All Fields]) OR "traditional medicine"[All Fields] OR ("traditional"[All Fields] AND "medicine"[All Fields])) OR (("asians"[MeSH Terms] OR "asians"[All Fields] OR "chinese"[All Fields] OR "chineses"[All Fields]) AND ("tradition"[All Fields] OR "tradition s"[All Fields] OR "traditional"[All Fields] OR "traditionals"[All Fields] OR "traditions"[All Fields])) OR (("asians"[MeSH Terms] OR "asians"[All Fields] OR "chinese"[All Fields] OR "chineses"[All Fields]) AND ("herbal medicine"[MeSH Terms] OR ("herbal"[All Fields] AND "medicine"[All Fields]) OR "herbal medicine"[All Fields] OR "herbalism"[All Fields] OR "herbal"[All Fields] OR "herbals"[All Fields]) AND "drug"[All Fields]) OR ("acupunctural"[All Fields] OR "acupuncture"[MeSH Terms] OR "acupuncture"[All Fields] OR "acupuncture therapy"[MeSH Terms] OR ("acupuncture"[All Fields] AND "therapy"[All Fields]) OR "acupuncture therapy"[All Fields] OR "acupuncture s"[All Fields] OR "acupunctured"[All Fields] OR "acupunctures"[All Fields] OR "acupuncturing"[All Fields]) OR ("moxibustion"[MeSH Terms] OR "moxibustion"[All Fields]) OR (("external"[All Fields] OR "externally"[All Fields] OR "externals"[All Fields]) AND ("therapeutics"[MeSH Terms] OR "therapeutics"[All Fields] OR "therapies"[All Fields] OR "therapy"[MeSH Subheading] OR "therapy"[All Fields] OR "therapy s"[All Fields] OR "therapys"[All Fields]))) AND ("randomized controlled trial"[Publication Type] OR "randomized controlled trials as topic"[MeSH Terms] OR "randomized controlled trial"[All Fields] OR "randomised controlled trial"[All Fields] OR ("random allocation"[MeSH Terms] OR ("random"[All Fields] AND "allocation"[All Fields]) OR "random allocation"[All Fields] OR "random"[All Fields] OR "randomization"[All Fields] OR "randomized"[All Fields] OR "randomisation"[All Fields] OR "randomisations"[All Fields] OR "randomise"[All Fields] OR "randomised"[All Fields] OR "randomising"[All Fields] OR "randomizations"[All Fields] OR "randomize"[All Fields] OR "randomizes"[All Fields] OR "randomizing"[All Fields] OR "randomness"[All Fields] OR "randoms"[All Fields]) OR ("drug therapy"[MeSH Subheading] OR ("drug"[All Fields] AND "therapy"[All Fields]) OR "drug therapy"[All Fields] OR "drug therapy"[MeSH Terms] OR ("drug"[All Fields] AND "therapy"[All Fields])) OR "randomly"[All Fields] OR ("clinical trials as topic"[MeSH Terms] OR ("clinical"[All Fields] AND "trials"[All Fields] AND "topic"[All Fields]) OR "clinical trials as topic"[All Fields] OR "trial"[All Fields] OR "trial s"[All Fields] OR "trialed"[All

Fields] OR "trialing"[All Fields] OR "trials"[All Fields]) OR ("meta"[Journal] OR "meta"[All Fields])) AND ("abdominal cavity"[MeSH Terms] OR "abdomen"[MeSH Terms] OR "Abdomens"[Title/Abstract]) AND ("ovarian neoplasms"[MeSH Terms] OR "neoplasm ovarian"[Title/Abstract] OR "ovarian neoplasm*"[Title/Abstract] OR ("neoplasm*"[All Fields] AND "Ovary"[Title/Abstract]) OR "ovary neoplasm"[Title/Abstract] OR "neoplasms ovarian"[Title/Abstract] OR "ovary cancer*"[Title/Abstract] OR ("cancer*"[All Fields] AND "Ovary"[Title/Abstract]) OR "ovarian cancer*"[Title/Abstract] OR ("cancer*"[All Fields] AND "Ovarian"[Title/Abstract]) OR "cancer of ovary"[Title/Abstract] OR "cancer of the ovary"[Title/Abstract])

（2）检索结果

列出检索到的文献总量及每个数据库的检索到的文献数量。

以术后肠梗阻为例，共检索到文献3920篇。知网（1254）、万方（522）、维普（213）、CBM（1817）、Pubmed（13）、embase（101）、cochrane（0）。

2.证据筛选和资料提取

（1）证据筛选和资料提取方法

将检索到的文献导入NoteExpress 3.0软件进行文献管理并去重。由两位研究者背对背检索并阅读题目和摘要进行初筛，对初筛后的文献阅读全文决定是否纳入。达成一致意见则纳入该研究，未达成一致意见则请指南起草负责人进行决定。提取纳入文献的作者、年份、发表期刊、干预人群、干预方式、结局指标等关键数据，以Excel表的形式汇总。

（2）纳入排除标准

纳入标准：研究类型为随机对照试验(randomized controlled trial，RCT)、meta分析；研究对象为病理明确诊断为卵巢癌。试验组干预措施：单个中药方剂或者中成药联合西医常规治疗；对照组干预措施:单纯西医常规治疗或空白对照；安慰剂+西医常规化疗治疗。

排除标准：无法下载全文的文献；统一研究多次发表，排除信息较少的文献；无法提取相关数据的文献。筛选过程由两名研究人员独立进行，意见不一致时研究团队进行讨论或请教第三方达成一致。

质量评价：使用系统评价偏倚风险工具AMSTAR-2量表对系统评价进行证据质量评价；使用Cochrane偏倚风险评价工具（ROB量表）对随机对照试验进行证据质量评价。

（3）证据筛选流程及结果（以肠梗阻为例）

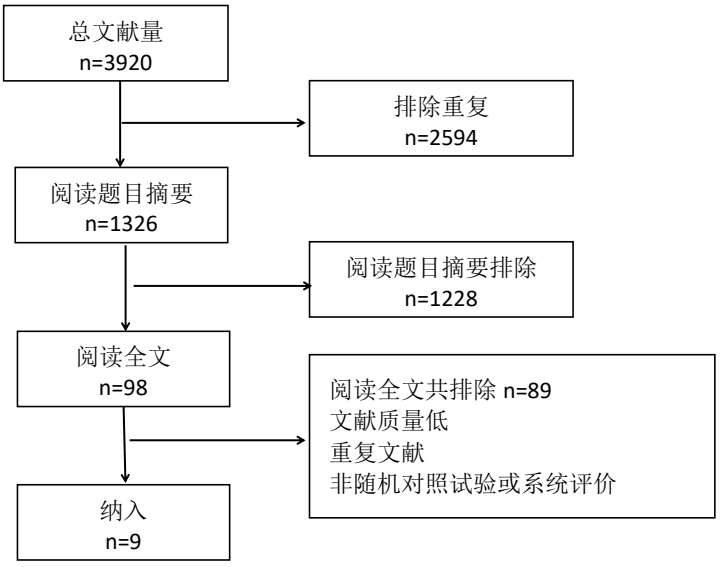

图1 证据筛选流程图

3.证据综合

若有高质量系统评价，且P、I、C、O与临床问题一致，无不包括在系统评价内的新研究则直接使用其结果；否则对纳入的随机对照实验进行Meta分析证据综合。

（六）证据分级

1.证据分级方法

采用GRADE方法对证据体进行汇总和质量评价，将证据体分为高（A）、中（B）、低（C）、极低（D）四个等级。证据质量见表5；影响证据质量的因素见表6。

表 5 GRADE 证据质量的定义

证据质量	等级具体描述
高（A）	我们非常确信真实的效应值接近效应估计值
中（B）	对效应估计值我们有中等程度的信心：真实值有可能接近估计值，但仍存在二者大不相同的可能性
低（C）	我们对效应估计值的确信程度有限：真实值可能与估计值大不相同
极低（D）	我们对效应估计值几乎没有信心：真实值很可能与估计值大不相同

表 6 影响证据质量的降级因素

具体因素	说明
偏倚风险	未正确随机分组；未进行分配方案的隐藏；未实施盲法（特别是当结局指标为主观性指标，其评估易受主观影响时）；研究对象失访过多，未进行意向性分析；选择性报告结果（尤其是仅报告观察到的阳性结果）；发现有疗效

	后研究提前终止
不一致性	如不同研究间存在大相径庭的结果，又没有合理的解释原因，可能意味着其疗效在不同情况下确实存在差异。差异可能源于人群（如药物在重症患者中的疗效可能更显著）、干预措施（如较高药物剂量的效果更显著），或结局指标（如随时间推移疗效减小）的不同。当结果存在不一致性而研究者未能意识到并给出合理解释时，需降低证据质量。
间接性	间接性可分两类：一是比较两种干预措施的疗效时，没有单独的研究直接比较二者的随机对照试验，但可能存在每种干预与安慰剂比较的多个随机对照试验，这些试验可用于进行二者之间疗效的间接比较，但提供的证据质量比单独的研究直接比较的随机对照试验要低；二是研究中所报告的人群、干预措施、对照措施、预期结局等与实际应用时存在重要差异
不精确性	当研究纳入的患者和观察事件相对较少而导致可信区间较宽时，需降低其证据质量
发表偏倚	如果很多研究（通常是小的、阴性结果的研究）未能公开，未纳入这些研究时，证据质量亦会减弱。极端的情况是当公开的证据仅局限于少数试验，而这些试验全部是企业赞助的，此时发表偏倚存在的可能性很大

备注：以上五个因素中任意一个因素，可根据其存在问题的严重程度，将证据质量降 1 级（严重）或 2 级（非常严重）。证据质量最多可被降级为极低，但注意不应该重复降级。

2. 证据概要表

表7 临床问题证据概要表

防治卵巢癌术后肠梗阻（肠粘连），合并与不合并中医药（中药、适宜技术）干预，哪种更有优势？

Q1：中药口服 vs 常规干预 for 卵巢癌术后腹胀腹痛

Certainty assessment							№；患者的		效果		Certainty	重要性
№；研究的	研究设计	偏倚风险	不一致性	间接性	精确性	其他考虑因素【注意事项】	口服中药	常规护理	相对 (95% CI)	绝对 (95% CI)		
肠鸣音恢复时间												
2	随机试验	严重 [a]	严重 [b]	严重 [c]	严重 [d]	无	151	151	-	MD **3.89** (11.74 到 0.07)	⊕◯◯◯ 极低	重要
首次肛门排期时间												
9	随机试验	严重 [a]	严重 [b]	严重 [c]	不严重	无	860	750	-	MD **1635.43** (16.81 到 4.36)	⊕◯◯◯ 极低	重要
腹胀持续时间 (用___评估: min)												
3	随机试验	严重 [a]	严重 [b]	不严重	不严重	无	278	190	-	MD **1025.41** (71.13 到 0.46)	⊕⊕◯◯ 低	关键
首次排便时间												

6	随机试验	严重 [a]	严重 [b]	严重 [c]	不严重	无	436	365	-	**0** (0 到 0)	⊕◯◯◯ 极低	重要

恶心呕吐持续时间

2	随机试验	严重 [a]	不严重	严重 [c]	不严重	无	178	90	-	OR **18** (19.76 到 16.24)	⊕⊕◯◯ 低	不重要

CI: Confidence interval; **MD:** Mean difference

Explanations

a. 纳入研究没有报告随机和分配隐藏
b. 异质性较高
c. 总样本不够，可信区间太宽
d. 结局指标存在间接性

Q2: 穴位帖敷 VS 西医常规治疗 for 卵巢癌术后腹胀腹痛

Certainty assessment							№；患者的		效果		Certainty	重要性
№；研究的	研究设计	偏倚风险	不一致性	间接性	精确性	其他考虑因素【注意事项】	[干预]	[对照]	相对 (95% CI)	绝对 (95% CI)		

发生率

5	随机试验	严重 [a]	严重	不严重	不严重	无	61/221 (27.6%)	144/220 (65.5%)	**比值比 0.18** (0.12 到 0.28)		⊕⊕◯◯ 低	关键

肠鸣音恢复时间

6	随机试验	严重 [a]	严重 [b]	严重 [c]	不严重	无	348	347	-	MD **5.94** (7.37 到 4.5)	⊕◯◯◯ 极低	重要

肛门首次排气时间

6	随机试验	严重 [a]	严重 [b]	严重 [c]	不严重	无	348	347	-	SMD **10.59 SD** (16.64 到 4.54)	⊕◯◯◯ 极低	重要

首次排便时间

6	随机试验	严重 [a]	严重 [b]	严重 [c]	不严重	无	348	347	-	SMD **10.65 SD 更低** (14.5 到 6.81)	⊕◯◯◯ 极低	重要

CI: Confidence interval; **MD:** Mean difference; **OR:** Odds ratio; **SMD:** Standardised mean difference

Explanations

a. 纳入研究均未报告分配隐藏和盲法
b. 参考结局指标存在间接性

Q3： 穴位按摩 vs 常规干预手法 for 卵巢癌术后腹胀腹痛

Certainty assessment							№；患者的		效果		Certainty	重要性
№；研究的	研究设计	偏倚风险	不一致性	间接性	精确性	其他考虑因素【注意事项】	[干预]	[对照]	相对 (95% CI)	绝对 (95% CI)		

发生率

6	随机试验	严重 [a]	严重 [b]	不严重	不严重	无	70/322 (21.7%)	156/322 (48.4%)	**比值比 0.12** (0.03 到 0.40)		⊕⊕◯◯ 低	关键

CI: Confidence interval; **OR:** Odds ratio

Explanations

a. 纳入研究均未报告分配隐藏和盲法

b. 异质性较高

Q4: 耳穴贴敷 vs 常规 for 卵巢癌术后腹胀腹痛

Certainty assessment							№；患者的		效果		Certainty	重要性
№；研究的	研究设计	偏倚风险	不一致性	间接性	精确性	其他考虑因素【注意事项】	[干预]	[对照]	相对 (95% CI)	绝对 (95% CI)		
肛门首次排气时间（术后 6h 组）												
4	随机试验	严重 [a]	不严重	严重 [b]	不严重	无	221	195	-	MD **5.26** (6.16 到 4.36)	⊕⊕◯◯ 低	重要
术后肠鸣音恢复时间												
4	随机试验	严重 [a]	不严重	严重 [b]	不严重	无	162	161	-	MD **6.24** (6.92 到 5.56)	⊕⊕◯◯ 低	重要

CI: Confidence interval; **MD:** Mean difference

Explanations

a. 纳入研究均未报告分配隐藏和盲法

b. 结局指标存在间接性

Q5：针灸干预 vs 西医常规干预 for 卵巢癌术后腹胀腹痛。

Certainty assessment							№；患者的		效果		Certainty	重要性
№；研究的	研究设计	偏倚风险	不一致性	间接性	精确性	其他考虑因素【注意事项】	[干预]	[对照]	相对 (95% CI)	绝对 (95% CI)		
临床有效率												
5	随机试验	严重 [a]	严重 [b]	不严重	不严重	无	121/127 (95.3%)	95/127 (74.8%)	**相对危险度 1.20** (1.02 到 1.42)		⊕⊕◯◯ 低	关键

CI: Confidence interval; **RR:** Risk ratio

Explanations

a. 纳入研究均未报告分配隐藏和盲法

b. 异质性较高

Q6: 中药保留灌肠 vs 西医常规治疗 for 卵巢癌术后腹胀腹痛

Certainty assessment							№；患者的		效果		Certainty	重要性
№；研究的	研究设计	偏倚风险	不一致性	间接性	精确性	其他考虑因素【注意事项】	[干预]	[对照]	相对 (95% CI)	绝对 (95% CI)		
有效率												
2	随机试验	严重 [a]	不严重	不严重	严重	无	50/57 (87.7%)	36/57 (63.2%)	**比值比 4.22** (1.61 到 11.03)		⊕⊕◯◯ 低	关键
首次排气												

7	随机试验	严重 [a]	严重 [b]	严重 [c]	不严重	无	326	315	-	MD **3.64** (4.32 到 2.97)	⊕◯◯◯ 极低	重要

CI: Confidence interval; **MD:** Mean difference; **OR:** Odds ratio

Explanations

a. 纳入研究均未报告分配隐藏和盲法

b.异质性较高

c.结局指标存在间接性

卵巢癌术后伤口不愈合，合并与不合并中医药（中药、适宜技术）干预，哪种更有优势？

Q1:康复新液 compared to 常规治疗 for 伤口难愈

Certainty assessment							№；患者的		效果		Certainty	重要性
№；研究的	研究设计	偏倚风险	不一致性	间接性	精确性	其他考虑因素【注意事项】	干预	placebo	相对 (95% CI)	绝对 (95% CI)		
愈合时间 7	随机试验	严重 [a]	严重 [b]	不严重	不严重	无	268	263	-	MD **-3.79** (-4.19 到-3.4)	⊕⊕◯◯ 低	重要

CI: Confidence interval; **MD:** Mean difference

a. 纳入研究未报告分配隐藏和盲法

b. 异质性高

Q2:生肌玉红膏 compared to 常规治疗 for 伤口难愈

Certainty assessment							№；患者的		效果		Certainty	重要性
№；研究的	研究设计	偏倚风险	不一致性	间接性	精确性	其他考虑因素【注意事项】	干预	placebo	相对 (95% CI)	绝对 (95% CI)		
愈合时间 5	随机试验	严重 [a]	严重 [b]	不严重	不严重	无	280	282	-	MD -8.43 (-12.35 到 -4.50)	⊕⊕◯◯ 低	重要
有效率 12	随机试验	严重 [a]	严重 [b]	不严重	不严重	无	499/528 (94.5%)	376/523 (71.9%)	**OR 6.77** (4.44 到 10.33)		⊕⊕◯◯ 低	重要

CI: Confidence interval; **MD:** Mean difference;**OR:** odds ratio

a.纳入研究未报告分配隐藏和盲法

b.纳入研究异质性较高

Q3:大黄芒硝外敷 compared to 常规治疗 for 伤口难愈

Certainty assessment							№；患者的		效果		Certainty	重要性
№；研究的	研究设计	偏倚风险	不一致性	间接性	精确性	其他考虑因素【注意事项】	干预	placebo	相对 (95% CI)	绝对 (95% CI)		

有效率 3	随机试验	严重 [a]	不严重	不严重	严重 [b]	无	145/162（91.2%）	103/167（72%）	OR6.96（3.58 到 13.54）		⊕⊕◯◯ 低	重要
愈合时间 3	随机试验	严重 [a]	严重 [c]	不严重	不严重	无	182	180		MD -4.15（-5.75 到 -2.54）	⊕⊕◯◯ 低	重要

CI: Confidence interval; **MD:** Mean difference;**OR:** odds ratio

a. 纳入研究未报告分配隐藏和盲法

b. 可信区间太宽

c. 异质性较高

Q4:龙血竭胶囊 compared to 常规治疗 for 伤口难愈

Certainty assessment							№；患者的		效果		Certainty	重要性
№；研究的	研究设计	偏倚风险	不一致性	间接性	精确性	其他考虑因素【注意事项】	干预	placebo	相对 (95% CI)	绝对 (95% CI)		
有效率 2	随机试验	严重 [a]	不严重	不严重	严重 [b]	无	76/76（100%）	54/75（72%）	OR 30.8（4.05 到 234.18)		⊕⊕◯◯ 低	重要

CI: Confidence interval; **MD:** Mean difference;**OR:** odds ratio

a. 纳入研究未报告分配隐藏和盲法

b. 样本量不足，可信区间太宽

卵巢癌术后淋巴囊肿，合并与不合并中医药（中药、适宜技术）干预，哪种更有优势？

Q1 大黄芒硝外用vs西医常规干预 for 卵巢癌术后淋巴囊肿

Certainty assessment							№；患者的		效果		Certainty	重要性
№；研究的	研究设计	偏倚风险	不一致性	间接性	精确性	其他考虑因素【注意事项】	[干预]	[对照]	相对 (95% CI)	绝对 (95% CI)		
囊肿消退时间												
5	随机试验	严重 [a]	不严重	不严重	严重 [b]	无	185	185	-	MD **3.82** (4.23 到 3.42)	⊕⊕◯◯ 低	关键
引流管留置时间												
5	随机试验	严重 [a]	不严重	不严重	严重 [b]	无	201	201	-	MD **2.32** (2.42 到 2.22)	⊕⊕◯◯ 低	关键
盆腔积液量												
5	随机试验	严重 [a]	不严重	不严重	严重 [b]	无	201	201	-	MD **56.26** (60.55 到 51.98)	⊕⊕◯◯ 低	重要
有效率												

7	随机试验	严重 [a]	不严重	不严重	严重 [c]	无	243/260 (93.5%)	195/260 (75.0%)	**比值比 4.84** (2.74 到 8.57)		⊕⊕◯◯ 低	关键

卵巢癌化疗、PARPi 导致的骨髓抑制，合并与不合并中医药（中药、适宜技术）哪种更有优势？

Q1 六君子汤 compared to 西医常规治疗 for 骨髓抑制

Certainty assessment							№；患者的		效果			
№；研究的	研究设计	偏倚风险	不一致性	间接性	精确性	其他考虑因素【注意事项】	六君子汤	placebo	相对 (95% CI)	绝对 (95% CI)	Certainty	重要性
白细胞减少发生率												
11	随机试验	严重	严重	不严重	不严重	无	51/379 (13.5%)	121/380 (31.8%)	**相对危险度 0.42** (0.32 到 0.56)	**185 较少每 1,000** (来自 217 较少到 140 较少)	⊕⊕◯◯ 低	

CI: Confidence interval; **RR:** Risk ratio

Explanations

a.纳入研究未报告分配隐藏和盲法

b.纳入研究异质性较高

Q2 当归补血汤 compared to 西医常规治疗 for 化疗后骨髓抑制

Certainty assessment							№；患者的		效果			
№；研究的	研究设计	偏倚风险	不一致性	间接性	精确性	其他考虑因素【注意事项】	当归补血汤	placebo	相对 (95% CI)	绝对 (95% CI)	Certainty	重要性
白细胞减少发生率												
7	随机试验	严重	严重	不严重	不严重	无	19/216 (8.8%)	60/216 (27.8%)	**相对危险度 0.32** (0.20 到 0.51)	**189 较少每 1,000** (来自 222 较少到 136 较少)	⊕⊕◯◯ 低	

CI: Confidence interval; **RR:** Risk ratio

Explanations

a.纳入研究未报告分配隐藏和盲法

b.纳入研究异质性较高

Q3 肾气汤 compared to 西医常规治疗 for 化疗后骨髓抑制

Certainty assessment							№；患者的		效果			
№；研究的	研究设计	偏倚风险	不一致性	间接性	精确性	其他考虑因素【注意事项】	肾气汤	placebo	相对 (95% CI)	绝对 (95% CI)	Certainty	重要性
白细胞减少发生率												
2	随机试验	不严重	不严重	不严重	严重	无	48/132(36.4%)	70/132(53.0%)	0.69(0.54 到 0.86)-	164 较少每 1000（来自 244 较少到 74 较少）)	⊕⊕◯ 低	重要

Explanations

a. 样本量不满足最优信息样本量

Q4 贞芪扶正颗粒 compared to 西医常规治疗 for 化疗后骨髓抑制

Certainty assessment							№；患者的		效果			
№；研究的	研究设计	偏倚风险	不一致性	间接性	精确性	其他考虑因素【注意事项】	贞芪扶正制剂	placebo	相对 (95% CI)	绝对 (95% CI)	Certainty	重要性
白细胞减少发生率												
13	随机试验	严重	不严重	不严重	严重	无	466	556	-	MD **0.55 更高** (0.43 更高到 00.71 更高)	⊕⊕◯◯ 低	重要

Explanations

a.纳入研究未报告分配隐藏和盲法

b.纳入研究异质性较高

Q5 复方皂矾丸 compared to 西医常规治疗 for 化疗后骨髓抑制

Certainty assessment							№；患者的		效果			
№；研究的	研究设计	偏倚风险	不一致性	间接性	精确性	其他考虑因素【注意事项】	复方皂矾丸	placebo	相对 (95% CI)	绝对 (95% CI)	Certainty	重要性
血小板减少发生率												
8	随机试验	严重	严重	不严重	不严重	无	72/313 (23.0%)	146/300 (48.7%)	**比值比 0.24** (0.16 到 0.36)	**301 较少每 1,000** (来自 355 较少到 232 较少)	⊕⊕◯◯ 低	重要

CI: Confidence interval; **OR:** Odds ratio

Explanations

a.纳入研究未报告分配隐藏和盲法

b.纳入研究异质性较高

Q6 芪胶升白胶囊 compared to 西医常规治疗 for 化疗后骨髓抑制

Certainty assessment							№；患者的		效果			
№；研究的	研究设计	偏倚风险	不一致性	间接性	精确性	其他考虑因素【注意事项】	芪胶升白胶囊	placebo	相对 (95% CI)	绝对 (95% CI)	Certainty	重要性
白细胞减少发生率												
6	随机试验	严重	严重	不严重	不严重	无	47/309 (15.2%)	106/273 (38.8%)	**相对危险度 0.41** (0.30 到 0.55)	**229 较少每 1,000** (来自 272 较少到 175 较少)	⊕⊕◯◯ 低	

CI: Confidence interval; **RR:** Risk ratio

Explanations

a.纳入研究未报告分配隐藏和盲法

b.纳入研究异质性较高

Q7 复方阿胶浆 compared to 西医常规治疗 for 化疗后骨髓抑制

Certainty assessment							№；患者的		效果			
№；研究的	研究设计	偏倚风险	不一致性	间接性	精确性	其他考虑因素【注意事项】	复方阿胶浆	placebo	相对 (95% CI)	绝对 (95% CI)	Certainty	重要性
白细胞计数												
6	随机试验	严重	严重	不严重	不严重	无	288	288		**MD -0.71 (-1.14 到 -0.28)**	⊕⊕◯◯ 低	重要

CI: Confidence interval; **OR:** Odds ratio

Explanations

a.纳入研究未报告分配隐藏和盲法

b.样本量不满足最优信息样本量

c.纳入研究异质性较高

Q8 地榆升白片 compared to 西医常规治疗 for 化疗后骨髓抑制

Certainty assessment							№；患者的		效果		Certainty	重要性

№；研究的	研究设计	偏倚风险	不一致性	间接性	精确性	其他考虑因素【注意事项】	地榆升白片	placebo	相对 (95% CI)	绝对 (95% CI)	
重度骨髓抑制发生率											
8	随机试验	严重	严重	不严重	不严重	无	173/271 (63.8%)	232/269 (86.2%)	**相对危险度 0.75** (0.69 到 0.83)	**216 较少 每 1,000** (来自 267 较少 到 147 较少)	⊕⊕◯◯ 低

Explanations

a.纳入研究未报告分配隐藏和盲法

b.纳入研究异质性较高

Q9 艾愈胶囊 compared to 西医常规治疗 for 化疗后骨髓抑制

	Certainty assessment						№；患者的		效果			
№；研究的	研究设计	偏倚风险	不一致性	间接性	精确性	其他考虑因素【注意事项】	艾愈胶囊	placebo	相对 (95% CI)	绝对 (95% CI)	Certainty	重要性
白细胞减少发生率												
3	随机试验	严重	严重	不严重	不严重	无	61/173 (35.3%)	23/204 (11.3%)	**比值比 0.31** 0.20 到 0.48)	**246 更 每 1,000** (来自 134 更 到 377 更)	⊕⊕◯◯ 低	重要

CI: Confidence interval; **OR:** Odds ratio

Explanations

a.纳入研究未报告分配隐藏和盲法

b.纳入研究异质性较高

c.样本量不满足最优信息样本量

Q10 生血宝颗粒 compared to 西医常规治疗 for 化疗后骨髓抑制

	Certainty assessment						№；患者的		效果			
№；研究的	研究设计	偏倚风险	不一致性	间接性	精确性	其他考虑因素【注意事项】	生血宝颗粒	placebo	相对 (95% CI)	绝对 (95% CI)	Certainty	重要性
白细胞												
2	随机试验	严重	严重	不严重	不严重	无	111	45	-	MD **1.56 更高** (1.22 更高 到 1.9 更高)	⊕⊕◯◯ 低	重要

CI: Confidence interval; **MD:** Mean difference

Explanations

a.纳入研究未报告分配隐藏和盲法

b.样本量不满足最优信息样本量

c.纳入研究异质性较高

Q11 针刺 compared to 西医常规治疗 for 化疗后骨髓抑制

Certainty assessment							№；患者的		效果			
№；研究的	研究设计	偏倚风险	不一致性	间接性	精确性	其他考虑因素【注意事项】	针刺	placebo	相对 (95% CI)	绝对 (95% CI)	Certainty	重要性
白细胞计数												
10	随机试验	严重	不严重	不严重	严重	无	356	366	相对危险度 0.88 (0.71 到 1.05)	**426 较少 每 1,000** (来自 477 较少 到 362 较少	⊕⊕◯ 低	重要

CI: Confidence interval; **RR:** Risk ratio

Explanations

a.纳入研究未报告分配隐藏和盲法

b.纳入研究异质性较高

Q12 穴位注射 compared to 西医常规治疗 for 化疗后骨髓抑制

Certainty assessment							№；患者的		效果			
№；研究的	研究设计	偏倚风险	不一致性	间接性	精确性	其他考虑因素【注意事项】	穴位注射	placebo	相对 (95% CI)	绝对 (95% CI)	Certainty	重要性
骨髓抑制发生率												
8	随机试验	严重	严重	不严重	不严重	无	300	292	相对危险度 4.58(2.72 到 7.70)-		⊕⊕◯◯ 低	重要

Explanations

a.纳入研究未报告分配隐藏和盲法

b.可信区间太宽

c.纳入研究异质性较高

卵巢癌化疗、PARPi 导致的消化道不良反应，合并与不合并中医药（中药、适宜技术）哪种更有优势？

Q13 旋覆代赭汤及其加味 compared to 西医常规治疗 for 化疗后恶心呕吐

Certainty assessment							№；患者的		效果			
№；研究的	研究设计	偏倚风险	不一致性	间接性	精确性	其他考虑因素【注意事项】	旋覆代赭石汤	placebo	相对 (95% CI)	绝对 (95% CI)	Certainty	重要性
止吐有效率												
12	随机试验	严重	不严重	严重	不严重	无	402/442 (91.0%)	310/406 (76.4%)	**相对危险度 1.20** (1.13 到 1.27)		⊕⊕◯◯ 低	重要

CI: Confidence interval; **RR:** Risk ratio

Explanations

a. 纳入研究未报告分配隐藏和盲法

b.样本量不满足最优信息样本量

Q14 加味香砂六君子汤联合 5 － HT3 受体拮抗剂类止吐药 compared to 西医常规治疗 for 化疗后恶心呕吐

Certainty assessment							№；患者的		效果			
№；研究的	研究设计	偏倚风险	不一致性	间接性	精确性	其他考虑因素【注意事项】	香砂六君子汤	placebo	相对 (95% CI)	绝对 (95% CI)	Certainty	重要性
呕吐缓解有效率												
5	随机试验	严重	严重	不严重	不严重	无	73/189 (38.6%)	57/187 (30.5%)	**比值比 1.45** (0.94 到 2.26)		⊕⊕◯◯ 低	重要

CI: Confidence interval; **OR:** Odds ratio

Explanations

a. 纳入研究未报告分配隐藏和盲法

b.样本量不满足最优信息样本量

c.纳入研究异质性较高

Q15 丁香柿蒂汤 compared to 西医常规治疗 for 化疗后呃逆呕吐

Certainty assessment							№；患者的		效果		Certainty	重要性

№；研究的	研究设计	偏倚风险	不一致性	间接性	精确性	其他考虑因素【注意事项】	丁香柿蒂汤	placebo	相对 (95% CI)	绝对 (95% CI)		
止吐有效率												
5	随机试验	严重	不严重	不严重	不严重	无	101/171 (59.1%)	124/178 (69.7%)	**相对危险度 0.86** (0.74 到 0.99)		⊕⊕◯ 低	重要

CI: Confidence interval; **RR:** Risk ratio

Explanations

a.纳入研究未报告分配隐藏和盲法

b.样本量不满足最优信息样本量

c.纳入研究异质性较高

Q16 灸法联合 5-HT3 受体拮抗剂 compared to 西医常规治疗 for 化疗后恶心呕吐

	Certainty assessment						№；患者的		效果			
№；研究的	研究设计	偏倚风险	不一致性	间接性	精确性	其他考虑因素【注意事项】	灸法	placebo	相对 (95% CI)	绝对 (95% CI)	Certainty	重要性
防治恶心呕吐有效率												
13	随机试验	严重	不严重	不严重	严重	无	513/583 (88.0%)	413/584 (70.7%)	**比值比 3.71** (2.64 到 5.22)		⊕⊕◯◯ 低	

CI: Confidence interval; **OR:** Odds ratio

Explanations

a. 纳入研究未报告分配隐藏和盲法

b. 可信区间太宽

c.纳入研究异质性较高

Q17 中药穴位贴敷联合 5-HT3 受体拮抗剂 compared to 西医常规治疗 for 化疗后恶心呕吐

	Certainty assessment						№；患者的		效果			
№；研究的	研究设计	偏倚风险	不一致性	间接性	精确性	其他考虑因素【注意事项】	穴位贴敷	placebo	相对 (95% CI)	绝对 (95% CI)	Certainty	重要性
恶心呕吐有效率												

12	随机试验	严重	严重	不严重	不严重	无	435/479 (90.8%)	305/443 (68.8%)	**比值比 4.71** (3.23 到 6.86)		⊕⊕◯◯ 低

CI: Confidence interval; **OR:** Odds ratio

Explanations

a. 纳入研究未报告分配隐藏和盲法

b..纳入研究异质性较高

Q18 足三里穴位注射联合 5-HT3 受体拮抗剂 compared to 西医常规治疗 for 化疗后恶心呕吐

Certainty assessment							№；患者的		效果			
№；研究的	研究设计	偏倚风险	不一致性	间接性	精确性	其他考虑因素【注意事项】	足三里穴位注射	placebo	相对 (95% CI)	绝对 (95% CI)	Certainty	重要性
止吐有效率												
6	随机试验	不严重	严重	不严重	不严重	无	163/199 (81.9%)	143/196 (73.0%)	**比值比 1.78** (1.06 到 2.96)		⊕⊕◯ 低	重要

CI: Confidence interval; **OR:** Odds ratio

Explanations

a. 纳入研究未报告分配隐藏和盲法

b. 可信区间太宽

c.纳入研究异质性较高

Q19 电针联合 5-HT3 受体拮抗剂 compared to 西医常规治疗 for 化疗后恶心呕吐

Certainty assessment							№；患者的		效果			
№；研究的	研究设计	偏倚风险	不一致性	间接性	精确性	其他考虑因素【注意事项】	电针	placebo	相对 (95% CI)	绝对 (95% CI)	Certainty	重要性
延迟呕吐发生率												
15	随机试验	严重	严重	不严重	严重	无	565/727 (77.7%)	421/767 (54.9%)	**相对危险度 1.40** (1.28 到 1.52)		⊕◯◯◯ 极低	重要

CI: Confidence interval; **RR:** Risk ratio

Explanations

a. 纳入研究未报告分配隐藏和盲法

b..纳入研究异质性较高

卵巢癌化疗导致的周围神经病变，合并或不合并中医药（中药、适宜技术）干预，哪种更有优势？

Q1:黄芪桂枝五物汤+常规化疗 compared to 常规化疗 for 神经毒性.

Certainty assessment							№；患者的		效果		Certainty	重要性
№；研究的	研究设计	偏倚风险	不一致性	间接性	精确性	其他考虑因素【注意事项】	黄芪桂枝五物汤口服+常规治疗	placebo	相对(95% CI)	绝对(95% CI)		
总发生率												
9	随机试验	严重 [a]	不严重	不严重	严重 [b]	无	135/270 (50.0%)	222/268 (82.8%)	**相对危险度 0.57** (0.40 到 0.81)		⊕⊕◯◯ 低	重要
严重发生率												
9	随机试验	严重 [a]	不严重	不严重	严重 [b]	无	39/270 (14.4%)	112/268 (41.8%)	**相对危险度 0.35** (0.25 到 0.48)		⊕⊕◯◯ 低	重要

CI: Confidence interval; **RR:** Risk ratio

Q2:补阳还五汤+常规化疗 compared to 常规化疗 for 神经毒性.

Certainty assessment							№；患者的		效果		Certainty	重要性
№；研究的	研究设计	偏倚风险	不一致性	间接性	精确性	其他考虑因素【注意事项】	补阳还五汤	placebo	相对(95% CI)	绝对(95% CI)		
有效率												
5	随机试验	严重 [a]	不严重	不严重	严重 [b]	无	44/150 (29.3%)	81/150 (54.0%)	**相对危险度 0.54** (0.41 到 0.72)		⊕⊕◯◯ 低	重要

CI: Confidence interval; **RR:** Risk ratio

Explanations
a. 纳入研究均为报告分配隐藏和盲法
b. 样本量不满足最优信息样本量

Q3:芍药甘草汤+常规化疗 compared to 常规化疗 for 神经毒性.

Certainty assessment	№；患者的	效果	Certainty	重要性

№；研究的	研究设计	偏倚风险	不一致性	间接性	精确性	其他考虑因素【注意事项】	芍药甘草汤	placebo	相对 (95% CI)	绝对 (95% CI)		
有效率												
2	随机试验	严重 [a]	不严重	不严重	严重 [b]	无	27/61 (44.3%)	39/51 (76.5%)	**相对危险度 0.67** (0.48 到 0.94)		⊕⊕◯◯ 低	重要

CI: Confidence interval; **RR:** Risk ratio

Explanations
a. 纳入研究均未报告分配隐藏和盲法
b. 样本量不满足最优信息样本量

Q4: 黄芪桂枝五物汤外洗+常规化疗 compared to 常规化疗 for 神经毒性.

Certainty assessment							№；患者的		效果		Certainty	重要性
№；研究的	研究设计	偏倚风险	不一致性	间接性	精确性	其他考虑因素【注意事项】	黄芪桂枝五物汤-外洗	placebo	相对 (95% CI)	绝对 (95% CI)		
有效率												
3	随机试验	严重 [a]	不严重	不严重	严重 [b]	无	23/56 (41.1%)	36/52 (69.2%)	**相对危险度 0.60** (0.41 到 0.85)		⊕⊕◯◯ 低	重要

CI: Confidence interval; **OR:** Odds ratio; **RR:** Risk ratio

Explanations
a. 纳入研究均未报告分配隐藏和盲法
b. 样本量不满足最优信息样本量

Q5: 针刺+常规化疗 compared to 常规化疗 for 神经毒性.

Certainty assessment							№；患者的		效果		Certainty	重要性
№；研究的	研究设计	偏倚风险	不一致性	间接性	精确性	其他考虑因素【注意事项】	针刺治疗	placebo	相对 (95% CI)	绝对 (95% CI)		
总有效率												
5	随机试验	严重 [a]	不严重	不严重	严重 [b]	无	126/233 (54.1%)	92/238 (38.7%)	**比值比 2.41** (1.56 到 3.72)	**216 更每 1,000** (来自 109 更 到 314 更)	⊕⊕◯◯ 低	重要
总有效率 - 感觉神经障碍												

5	随机试验	严重[a]	不严重	不严重	严重[b]	无	114/154 (74.0%)	85/159 (53.5%)	**比值比 2.57** (1.59 到 4.17)	**212 更每 1,000** (来自 112 更 到 293 更)	⊕⊕◯◯ 低	关键

总有效率 - 运动神经障碍

3	随机试验	严重[a]	不严重	不严重	严重[b]	无	12/79 (15.2%)	7/79 (8.9%)	**比值比 1.85** (0.69 到 4.97)	**64 更 每 1,000** (来自 26 较少 到 237 更)	⊕⊕◯◯ 低	关键

CI: Confidence interval; **OR:** Odds ratio

Explanations
a. 纳入研究均未报告分配隐藏和盲法
b. 样本量不满足最优信息样本量

卵巢癌化疗后脱发，合并或不合并中医药（中药、适宜技术）干预，哪种更有优势？

Q1: 四君子汤加减+常规化疗 compared to 常规化疗 for 脱发

Certainty assessment							№；患者的		效果		Certainty	重要性
№；研究的	研究设计	偏倚风险	不一致性	间接性	精确性	其他考虑因素【注意事项】	四君子汤+常规 vs 常规	placebo	相对 (95% CI)	绝对 (95% CI)		
有效率												
7	随机试验	严重[a]	不严重	不严重	严重[a]	无	80/389 (20.6%)	116/338 (34.3%)	**相对危险度 0.55** (0.36 到 0.85)		⊕⊕◯◯ 低	关键

CI: Confidence interval; **RR:** Risk ratio

Explanations
a. 纳入研究均未报告分配隐藏和盲法
b. 样本量不满足最优信息样本量

Q2: 冰帽+常规化疗 compared to 常规化疗 for 脱发

Certainty assessment							№；患者的		效果		Certainty	重要性
№；研究的	研究设计	偏倚风险	不一致性	间接性	精确性	其他考虑因素【注意事项】	冰帽+常规 vs 常规	placebo	相对 (95% CI)	绝对 (95% CI)		
有效率												
27	随机试验	严重[a]	不严重	不严重	严重[b]	无	613/1101 (55.7%)	488/1101 (44.3.0%)	**相对危险度 61** (55 到 67)		⊕⊕◯◯ 低	关键

CI: Confidence interval; **RR:** Risk ratio

Explanations
a. 纳入研究均未报告分配隐藏和盲法
b. 样本量不满足最优信息样本量

卵巢癌使用抗血管生成靶向药物引起血压升高，合并与不合并中医药（中药、适宜技术）干预，哪种更有优势？

Q1：穴位贴敷 compared to 西医常规治疗 for 高血压

Certainty assessment							№；患者的		效果		Certainty	重要性
№；研究的	研究设计	偏倚风险	不一致性	间接性	精确性	其他考虑因素【注意事项】	[干预]	[对照]	相对 (95% CI)	绝对 (95% CI)		
有效率	随机试验	严重 a	严重 b	不严重	不严重	无	1280	1278	**相对危险度 1.23** (1.15 到 1.32)		⊕⊕◯◯ 低	关键

Explanations
a. 部分未说明随机方式，均未提及分配隐藏及盲法
b.异质性较高

Q2：耳穴 compared to 西医常规治疗 for 高血压

Certainty assessment							№；患者的		效果		Certainty	重要性
№；研究的	研究设计	偏倚风险	不一致性	间接性	精确性	其他考虑因素【注意事项】	[干预]	[对照]	相对 (95% CI)	绝对 (95% CI)		
有效率	随机试验	严重 a	严重 b	不严重	不严重	无	1009	1007	**相对危险度 1.22** (1.17 到 1.26)-		⊕⊕◯◯ 低	关键

Explanations
a. 部分未说明随机方式，均未提及分配隐藏及盲法
b.异质性较高

Q3：针刺 compared to 西医常规治疗 for 高血压

Certainty assessment							№；患者的		效果		Certainty	重要性
№；研究的	研究设计	偏倚风险	不一致性	间接性	精确性	其他考虑因素【注意事项】	[干预]	[对照]	相对 (95% CI)	绝对 (95% CI)		
有效率	随机试验	严重 a	严重 b	不严重	不严重	无	426	424	**相对危险度 4.28** (2.8 到 6.53)		⊕⊕◯◯ 低	关键

Explanations
a. 部分未说明随机方式，均未提及分配隐藏及盲法
b.异质性较高

Q4：太极拳 compared to 西医常规治疗 for 高血压

Certainty assessment							№；患者的		效果		Certainty	重要性
№；研究的	研究设计	偏倚风险	不一致性	间接性	精确性	其他考虑因素【注意事项】	[干预]	[对照]	相对 (95% CI)	绝对 (95% CI)		
收缩压	随机试验	严重 a	严重 b	不严重	不严重	无	1612	1610		WMD-11.3 (-14.6 到-8.0)	⊕⊕◯◯ 低	关键
舒张压	随机试验	严重 a	不严重	不严重	严重	无	1612	1610		WMD=-4.8，（–6.4 到 –3.1）	⊕⊕◯◯ 低	关键

Explanations
a. 部分未说明随机方式，均未提及分配隐藏及盲法

Q5：气功 compared to 西医常规治疗 for 高血压

Certainty assessment							№；患者的		效果		Certainty	重要性
№；研究的	研究设计	偏倚风险	不一致性	间接性	精确性	其他考虑因素【注意事项】	[干预]	[对照]	相对 (95% CI)	绝对 (95% CI)		
收缩压	随机试验	严重 [a]	非常严重 [b]	不严重	不严重	无	185	185		WMD=-18.2（-21.3-−15.2）	⊕◯◯◯ 极低	关键

Explanations

a. 部分未说明随机方式，均未提及分配隐藏及盲法

b. 异质性非常高

Q6：半夏白术天麻汤 compared to 西医常规治疗 for 高血压

Certainty assessment							№；患者的		效果		Certainty	重要性
№；研究的	研究设计	偏倚风险	不一致性	间接性	精确性	其他考虑因素【注意事项】	[干预]	[对照]	相对 (95% CI)	绝对 (95% CI)		
降压疗效	随机试验	严重 [a]	严重 [b]	不严重	不严重	无	-	-	**相对危险度 1.18** (1.12 到 1.24)	-	⊕⊕◯◯ 低	关键

CI: Confidence interval; RR: Risk ratio

a.部分未说明随机方式，均未提及分配隐藏及盲法

b.异质性较高

Q7：天麻钩藤饮 compared to 西医常规治疗 for 高血压

Certainty assessment							№；患者的		效果		Certainty	重要性
№；研究的	研究设计	偏倚风险	不一致性	间接性	精确性	其他考虑因素【注意事项】	[干预]	[对照]	相对 (95% CI)	绝对 (95% CI)		
降压疗效	随机试验	严重 [a]	不严重	不严重	不严重	强烈怀疑存在发表偏倚 [b]	199/212(93.9%)	163/206(79.1%)	**相对危险度 1.19** (1.10 到 1.28)	-	⊕⊕◯◯ 低	关键

CI: Confidence interval; RR: Risk ratio

a.均未提及分配隐藏及盲法

b.研究分布不对称，Egger's 法检测说明存在发表偏倚

Q8：清肝降压胶囊 compared to 西医常规治疗 for 高血压

Certainty assessment							№；患者的		效果		Certainty	重要性
№；研究的	研究设计	偏倚风险	不一致性	间接性	精确性	其他考虑因素【注意事项】	[干预]	[对照]	相对 (95% CI)	绝对 (95% CI)		
DBP	随机试验	严重 [a]	不严重	不严重	不严重	强烈怀疑存在发表偏倚 [b]	496	496	-	MD **-0.99** (-1.12 到 -0.86)	⊕⊕◯◯ 低	关键

CI: Confidence interval; MD: Mean difference; SMD: Standardised mean difference

a.部分未说明随机方式，均未提及分配隐藏及盲法

b.未采用漏斗图分析发表偏倚

卵巢癌化疗或靶向治疗期间出现手足皮肤不良反应，中医药（中药、中医适宜技术）的疗效及安全性如何？

Q1：活血化瘀中药外洗 compared to 常规治疗 for 手足综合征.

Certainty assessment	№；患者的	效果	Certainty	重要性

№；研究的	研究设计	偏倚风险	不一致性	间接性	精确性	其他考虑因素【注意事项】	中药外洗+常规 vs 常规 for 手足综合征	placebo	相对 (95% CI)	绝对 (95% CI)		
总有效率												
9	随机试验	严重 [a]	严重	不严重	不严重	无	318/370 (85.9%)	162/322 (50.3%)	**RR 1.72** (1.53 到 1.94)	-	⊕⊕◯◯ 低	关键

CI: Confidence interval; **OR:** Odds ratio

Explanations

a. 纳入研究均未报告分配隐藏和盲法\

b. 不一致性较大

Q2： 康复新液 compared to 常规治疗 for 手足综合征.:

Certainty assessment							№；患者的		效果		Certainty	重要性
№；研究的	研究设计	偏倚风险	不一致性	间接性	精确性	其他考虑因素【注意事项】	康复新液 for 手足综合征	placebo	相对 (95% CI)	绝对 (95% CI)		
有效率												
2	随机试验	严重 [a]	不严重	严重 [b]	不严重	无	60/64 (93.8%)	31/49 (63.3%)	**RR 1.48** (1.18 到 1.85)	-	⊕⊕◯◯ 低	关键

CI: Confidence interval; **OR:** Odds ratio

Explanations

a.纳入研究均未报告分配隐藏和盲法；

b. 以皮肤皲裂愈合程度为结局指标，存在间接性

Q3：灸法 compared to 常规治疗 for 手足综合征.

Certainty assessment							№；患者的		效果		Certainty	重要性
№；研究的	研究设计	偏倚风险	不一致性	间接性	精确性	其他考虑因素【注意事项】	灸法 for 手足综合征	placebo	相对 (95% CI)	绝对 (95% CI)		
有效率												
2	随机试验	严重 [a]	严重 [b]	不严重	不严重	无	44/58 (75.9%)	29/58 (50.0%)	**RR 1.52** (1.17 到 1.97)	-	⊕⊕◯◯ 低	关键

CI: Confidence interval; **OR:** Odds ratio

Explanations

a. 纳入研究均未报告分配隐藏和盲法

b. 不一致性较大

晚期卵巢癌，中医单用或联合西药维持治疗的疗效及安全性如何？

Q1：理冲汤加减 compare to 西医常规治疗/安慰剂 for 卵巢癌维持治疗（冲任失调证）

Certainty assessment							№；患者的		效果		Certainty	重要性
№；研究的	研究设计	偏倚风险	不一致性	间接性	精确性	其他考虑因素【注意事项】	[干预]	[对照]	相对 (95% CI)	绝对 (95% CI)		
中位无进展生存期（mPFS）												
2	随机试验	不严重	严重 [a]	不严重	不严重	无	191	183	-	MD **1.84 更高** (1.55 更高到 2.12 更高)	⊕⊕⊕◯ Moderate	关键
生存质量												

3	随机试验	严重 [b]	不严重	不严重	严重 [c]	无	112	118	-	MD **6.78 更高** (4.53 更高到 9.03 更高)	⊕⊕◯◯ 低	重要

中医症状

2	随机试验	严重 [b]	严重 [a]	不严重	不严重	无	106	112	-	MD **1.71 更低** (2 更低 到 1.43 更低)	⊕⊕◯◯ 低	重要

CI: Confidence interval; **MD:** Mean difference

Explanations

a. 异质性较高

b. 纳入研究均未报告分配隐藏和盲法

c. 样本量不满足最优信息样本量

Q2: 桂枝茯苓丸加减 compare to 西医常规治疗 for 卵巢癌维持治疗（气滞血瘀证）

Certainty assessment							№：患者的		效果		Certainty	重要性
№：研究的	研究设计	偏倚风险	不一致性	间接性	精确性	其他考虑因素【注意事项】	[干预]	[对照]	相对 (95% CI)	绝对 (95% CI)		
客观缓解率 ORR												
2	随机试验	严重 [a]	不严重	不严重	严重 [b]	无	67/80 (83.8%)	49/80 (61.3%)	**相对危险度 1.37** (1.12 到 1.67)	**227 更 每 1,000** (来自 74 更到 410 更)	⊕⊕◯◯ 低	关键
CA125 水平												
3	随机试验	严重 [a]	严重 [c]	不严重	严重 [b]	无	124	124	-	MD **21.1 更低** (23.08 更低到 19.13 更低)	⊕◯◯◯ 极低	重要

CI: Confidence interval; **MD:** Mean difference; **RR:** Risk ratio

Explanations

a. 纳入研究均未报告分配隐藏和盲法

b. 总样本量不够

c. 异质性较高

Q3: 附子理中汤合三棱煎加减 compare to 西医常规治疗 for 卵巢癌维持治疗（寒凝血瘀证）

Certainty assessment							№：患者的		效果		Certainty	重要性
№：研究的	研究设计	偏倚风险	不一致性	间接性	精确性	其他考虑因素【注意事项】	[干预]	[对照]	相对 (95% CI)	绝对 (95% CI)		
客观缓解率												

2	随机试验	严重 [a]	不严重	不严重	严重 [b]	无	91/96 (94.8%)	78/96 (81.3%)	**相对危险度 1.17** (1.05 到 1.30)		⊕⊕◯◯ 低	关键
CD3+												
2	随机试验	严重 [a]	不严重	不严重	严重 [b]	无	96	96	-	MD **16.98** (15.01 到 18.94)	⊕⊕◯◯ 低	重要
CD4+												
2	随机试验	严重 [a]	不严重	不严重	严重 [b]	无	96	96	-	MD **10.85** (9.62 到 12.08)	⊕⊕◯◯ 低	重要
CD8+												
2	随机试验	严重 [a]	不严重	不严重	严重 [b]	无	96	96	-	MD **7.84** (6.37 到 9.3)	⊕⊕◯◯ 低	重要
中医证候												
2	随机试验	严重 [a]	不严重	不严重	严重 [b]	无	96	96	-	MD **7.34** (8.29 到 6.39)	⊕⊕◯◯ 低	关键
生存质量（KPS 评分）												
2	随机试验	严重 [a]	不严重	不严重	严重 [b]	无	96	96	-	MD **7.03** (3.32 到 10.74)	⊕⊕◯◯ 低	关键
HE4												
2	随机试验	严重 [a]	不严重	不严重	严重 [b]	无	96	96	-	MD **34.77** (37.33 到 32.21)	⊕⊕◯◯ 低	重要
CA125												
2	随机试验	严重 [a]	严重 [c]	不严重	严重 [b]	无	96	96	-	MD **20.17** (22.34 到 18)	⊕◯◯◯ 极低	重要

CI: Confidence interval; **MD:** Mean difference; **RR:** Risk ratio

Explanations

a. 纳入研究均未报告分配隐藏和盲法

b. 样本量不够

c. 异质性较高

Q4: 真武汤加减 compare to 西医常规治疗 for 卵巢癌维持治疗（阳虚水泛证）

Certainty assessment							№：患者的		效果		Certainty	重要性
№：研究的	研究设计	偏倚风险	不一致性	间接性	精确性	其他考虑因素【注意事项】	[干预]	[对照]	相对 (95% CI)	绝对 (95% CI)		
生存质量（KPS 评分）												

3	随机试验	严重 [a]	不严重	不严重	严重 [b]	无	106	104	-	MD **7.65 更高** (5.9 更高到 9.39 更高)	⊕⊕◯◯ 低	关键

腹腔积液有效率

2	随机试验	严重 [a]	不严重	不严重	严重 [b]	无	69/80 (86.3%)	45/80 (56.3%)	**相对危险度 1.53** (1.24 到 1.90)		⊕⊕◯◯ 低	关键

CI: Confidence interval; **MD:** Mean difference; **RR:** Risk ratio

Explanations

a. 纳入研究均未报告分配隐藏和盲法

b. 总样本不够

Q5: 大七气汤 compared to 西医常规治疗 for 维持治疗期卵巢癌（瘀毒互结证）

Certainty assessment							№；患者的		效果		Certainty	重要性
№；研究的	研究设计	偏倚风险	不一致性	间接性	精确性	其他考虑因素【注意事项】	meta	placebo	相对 (95% CI)	绝对 (95% CI)		
客观缓解率												
2	随机试验	严重 [a]	严重 [b]	不严重	不严重	无	65/86 (75.6%)	35/72 (48.6%)	比值比 3.22 (1.63 到 6.33)		⊕⊕◯◯ 低	关键

CI: Confidence interval; **OR:** Odds ratio

Explanations

a. 纳入研究没有报告随机和分配隐藏

b. 不一致性较大

Q6: 复方斑蝥胶囊 compare to 西医常规治疗 for 卵巢癌维持治疗

Certainty assessment							№；患者的		效果		Certainty	重要性
№；研究的	研究设计	偏倚风险	不一致性	间接性	精确性	其他考虑因素【注意事项】	meta	placebo	相对 (95% CI)	绝对 (95% CI)		
疾病控制率（DCR）												
3	随机试验	严重 [a]	不严重	不严重	严重 [c]	无	88/113 (77.9%)	70/113 (61.9%)	**相对危险度 1.26** (1.06 到 1.50)	**161 更每 1,000** (来自 37 更到 310 更)	⊕⊕◯◯ 低	关键
肝功能损伤												
3	随机试验	严重 [a]	严重 [b]	不严重	严重 [c]	无	18/113 (15.9%)	30/113 (26.5%)	**比值比 0.51** (0.26 到 1.01)	**110 较少每 1,000** (来自 180 较少到 2 更)	⊕◯◯◯ 极低	重要
胃肠道损伤												

3	随机试验	严重 [a]	不严重	不严重	不严重	无	21/113 (18.6%)	31/113 (27.4%)	**相对危险度 0.70** (0.44 到 1.13)	**82 较少 每 1,000** (来自 154 较少 到 36 更)	⊕⊕⊕◯ 中	重要
周围神经病变												
3	随机试验	严重 [a]	不严重	不严重	不严重	无	18/113 (15.9%)	41/113 (36.3%)	**相对危险度 0.44** (0.28 到 0.69)	**203 较少 每 1,000** (来自 261 较少 到 112 较少)	⊕⊕⊕◯ 中	重要

CI: Confidence interval; **OR:** Odds ratio; **RR:** Risk ratio

Explanations

a. 纳入研究均未报告分配隐藏和盲法

b. 异质性较高

c. 样本量不满足最优信息样本量

Q7：西黄丸 compare to 西医常规治疗 for 卵巢癌维持治疗

Certainty assessment							№：患者的		效果		Certainty	重要性
№：研究的	研究设计	偏倚风险	不一致性	间接性	精确性	其他考虑因素【注意事项】	[干预]	[对照]	相对 (95% CI)	绝对 (95% CI)		
客观缓解率												
2	随机试验	严重 [a]	不严重	不严重	严重 [b]	无	65/70 (92.9%)	50/70 (71.4%)	**相对危险度 1.30** (1.11 到 1.53)		⊕⊕◯◯ 低	关键

CI: Confidence interval; **RR:** Risk ratio

Explanations

a. 纳入研究均未报告分配隐藏和盲法

b. 总样本不够

Q8: 艾迪注射液 compared to 西医常规治疗 for 卵巢癌维持治疗

Certainty assessment							№：患者的		效果		Certainty	重要性
№：研究的	研究设计	偏倚风险	不一致性	间接性	精确性	其他考虑因素【注意事项】	meta	placebo	相对 (95% CI)	绝对 (95% CI)		
客观缓解率												
5	随机试验	严重 [a]	严重 [b]	不严重	不严重	无	144/178 (80.9%)	108/180 (60.0%)	不可估计的		⊕⊕◯◯ 低	关键
生存质量												
5	随机试验	严重 [a]	严重 [b]	不严重	不严重	无	158/178 (88.8%)	124/180 (68.9%)	**比值比 3.69** (1.86 到 7.30)		⊕⊕◯◯ 低	关键
胃肠道反应												
4	随机试验	严重 [a]	严重 [b]	不严重	不严重	无	12/129 (9.3%)	41/128 (32.0%)	**比值比 0.19** (0.09 到 0.40)		⊕⊕◯◯ 低	重要

骨髓抑制

4	随机试验	严重 [a]	严重 [b]	不严重	严重 [c]	无	20/129 (15.5%)	46/128 (35.9%)	**比值比 0.29** (0.15 到 0.55)		⊕◯◯◯ 极低	重要

肝肾功能损伤

2	随机试验	严重 [a]	严重 [b]	不严重	严重 [c]	无	4/73 (5.5%)	5/75 (6.7%)	**比值比 0.79** (0.20 到 3.17)		⊕◯◯◯ 极低	重要

CI: Confidence interval; **OR:** Odds ratio

Explanations

a. 纳入研究未报告随机和隐藏分配

b. 异质性较高

c. 总样本不够，可信区间太宽

Q9: 康艾注射液 compared to 西医常规治疗 for 卵巢癌维持治疗

Certainty assessment							№；患者的		效果		Certainty	重要性
№；研究的	研究设计	偏倚风险	不一致性	间接性	精确性	其他考虑因素【注意事项】	meta	placebo	相对 (95% CI)	绝对 (95% CI)		
客观缓解率												
5	随机试验	严重 [a]	严重 [b]	不严重	不严重	无	166/195 (85.1%)	121/190 (63.7%)	比值比 3.30 (1.50 到 7.25)		⊕⊕◯◯ 低	关键
生存质量												
4	随机试验	严重 [a]	严重 [b]	不严重	不严重	无	153/175 (87.4%)	128/171 (74.9%)	比值比 2.35 (1.24 到 4.46)		⊕⊕◯◯ 低	重要
肝肾功能												
2	随机试验	严重 [a]	严重 [b]	不严重	严重 [c]	无	12/80 (15.0%)	18/78 (23.1%)	比值比 0.58 (0.25 到 1.34)		⊕◯◯◯ 极低	重要
胃肠道反应												
3	随机试验	严重 [a]	严重 [b]	不严重	严重 [c]	无	32/140 (22.9%)	78/138 (56.5%)	比值比 0.21 (0.12 到 0.36)		⊕◯◯◯ 极低	重要

CI: Confidence interval; **OR:** Odds ratio

Explanations

a. 纳入研究未报告分配隐藏和盲法

b. 异质性较高

c. 总样本不够，置信区间太宽

Q10: 复方苦参注射液 compare to 西医常规治疗 for 卵巢癌维持治疗

Certainty assessment							№；患者的		效果		Certainty	重要性
№；研究的	研究设计	偏倚风险	不一致性	间接性	精确性	其他考虑因素【注意事项】	[干预]	[对照]	相对 (95% CI)	绝对 (95% CI)		
客观缓解率												

9	随机试验	严重 [a]	不严重	不严重	严重 [b]	无	320/408 (78.4%)	227/407 (55.8%)	**相对危险度 1.41** (1.28 到 1.56)	**229 更 每 1,000** (来自 156 更 到 312 更)	⊕⊕◯◯ 低	关键
生存质量												
2	随机试验	严重 [a]	不严重	不严重	严重 [b]	无	75/88 (85.2%)	58/82 (70.7%)	**相对危险度 1.22** (1.04 到 1.43)	**156 更 每 1,000** (来自 28 更 到 304 更)	⊕⊕◯◯ 低	关键
骨髓抑制												
3	随机试验	严重 [a]	不严重	不严重	严重 [b]	无	141	141	-	MD **1.47 更高** (1.1 更高 到 1.84 更高)	⊕⊕◯◯ 低	重要
肝功能												
4	随机试验	严重 [a]	不严重	不严重	严重 [b]	无	27/209 (12.9%)	52/210 (24.8%)	**相对危险度 0.52** (0.35 到 0.78)		⊕⊕◯◯ 低	重要
肾功能												
4	随机试验	严重 [a]	不严重	不严重	严重 [b]	无	23/209 (11.0%)	48/210 (22.9%)	**相对危险度 0.48** (0.31 到 0.75)		⊕⊕◯◯ 低	重要

CI: Confidence interval; **MD:** Mean difference; **RR:** Risk ratio

Explanations

a. 纳入研究均未报告分配隐藏和盲法

b. 样本量不满足最优信息样本量

Q11: 参芪扶正注射液 compared to 西医常规治疗 for 卵巢癌维持治疗

Certainty assessment							№: 患者的		效果		Certainty	重要性
№: 研究的	研究设计	偏倚风险	不一致性	间接性	精确性	其他考虑因素【注意事项】	[干预]	[对照]	相对 (95% CI)	绝对 (95% CI)		
客观缓解率												
4	随机试验	严重 [a]	不严重	不严重	严重 [b]	无	140/177 (79.1%)	102/170 (60.0%)	**相对危险度 2.68** (1.63 到 4.41)	**1,000 更 每 1,000** (来自 378 更 到 1,000 更)	⊕⊕◯◯ 低	关键
生存质量												
5	随机试验	严重 [a]	不严重	不严重	严重 [b]	无	98/199 (49.2%)	55/205 (26.8%)	**相对危险度 2.75** (1.79 到 4.24)	**470 更 每 1,000** (来自 212 更 到 869 更)	⊕⊕◯◯ 低	关键
胃肠道反应												

3	随机试验	严重 [a]	严重 [c]	不严重	严重 [d]	无			**相对危险度 0.35** (0.21 到 0.60)	**0 较少 每 1,000** (来自 1 较少 到 0 较少)	⊕◯◯◯ 极低	重要

脱发

2	随机试验	严重 [a]	严重 [c]	不严重	严重 [d]	无			**相对危险度 0.19** (0.07 到 0.54)	**0 较少 每 1,000** (来自 1 较少 到 0 较少)	⊕◯◯◯ 极低	重要

白细胞减少

3	随机试验	严重 [a]	不严重	不严重	严重 [d]	无			**相对危险度 0.38** (0.21 到 0.66)	**0 较少 每 1,000** (来自 1 较少 到 0 较少)	⊕⊕◯◯ 低	重要

血小板减少

3	随机试验	严重 [a]	不严重	不严重	严重 [d]	无			**相对危险度 0.40** (0.21 到 0.76)	**0 较少 每 1,000** (来自 1 较少 到 0 较少)	⊕⊕◯◯ 低	重要

CI: Confidence interval; **RR:** Risk ratio

Explanations

a. 纳入研究均未报告分配隐藏和盲法

b. 样本量不满足最优信息样本量

c. 异质性较大

d. 总样本量不够

Q12: 参麦注射液 compared to 西医常规治疗 for 卵巢癌维持治疗

Certainty assessment							№: 患者的		效果		Certainty	重要性
№: 研究的	研究设计	偏倚风险	不一致性	间接性	精确性	其他考虑因素【注意事项】	[干预]	[对照]	相对 (95% CI)	绝对 (95% CI)		

客观缓解率）

4	随机试验	严重 [a]	不严重	不严重	严重 [b]	无	67/105 (63.8%)	55/102 (53.9%)	**相对危险度 1.19** (0.94 到 1.49)	**102 更 每 1,000** (来自 32 较少 到 264 更)	⊕⊕◯◯ 低	关键

生存质量

2	随机试验	严重 [a]	不严重	不严重	严重 [b]	无	27/48 (56.3%)	11/46 (23.9%)	**相对危险度 2.35** (1.33 到 4.18)	**323 更 每 1,000** (来自 79 更 到 760 更)	⊕⊕◯◯ 低	关键

胃肠不良反应

2	随机试验	严重 [a]	不严重	不严重	严重 [b]	无	21/57 (36.8%)	41/56 (73.2%)	**相对危险度 0.50** (0.35 到 0.73)	**366 较少每 1,000** (来自 476 较少到 198 较少)	⊕⊕◯◯ 低	重要

骨髓抑制

2	随机试验	严重 [a]	不严重	不严重	严重 [b]	无	19/57 (33.3%)	34/56 (60.7%)	**相对危险度 0.55** (0.36 到 0.84)	**273 较少每 1,000** (来自 389 较少到 97 较少)	⊕⊕◯◯ 低	重要

CI: Confidence interval; **RR:** Risk ratio

Explanations

a. 纳入研究均未报告分配隐藏和盲法

b. 样本量不满足最优信息样本量

卵巢癌患者，中医药（中药、适宜技术）单用或者联合西医常规干预癌因性疲乏的疗效及安全性如何？

Q1：人参养荣汤 compared to 西医常规治疗 for 癌因性疲乏

Certainty assessment							№：患者的		效果		Certainty	重要性
№：研究的	研究设计	偏倚风险	不一致性	间接性	精确性	其他考虑因素【注意事项】	[干预]	[对照]	相对 (95% CI)	绝对 (95% CI)		
BFI 评分改善												
2	随机试验	严重 [a]	严重 [b]	不严重	不严重	无	49	51	-	MD **10.31** (4.07 到 26.07)	⊕⊕◯◯ 低	关键
疲乏对一般活动的影响												
2	随机试验	严重 [a]	严重 [b]	不严重	不严重	无	49	51	-	MD **4.52** (1.94 到 10.49)	⊕⊕◯◯ 低	重要
疲乏对行走能力的影响												
2	随机试验	严重 [a]	严重 [b]	不严重	不严重	无	49	51	-	MD **3.17** (1.4 到 7.18)	⊕⊕◯◯ 低	重要

CI: Confidence interval; **MD:** Mean difference

Explanations

a. 未报告盲法和分配隐藏

b. 异质性较高

Q2：补中益气汤 compared to 西医常规治疗 for 癌因性疲乏

Certainty assessment	№：患者的	效果	Certainty	重要性

№；研究的	研究设计	偏倚风险	不一致性	间接性	精确性	其他考虑因素【注意事项】	[干预]	[对照]	相对 (95% CI)	绝对 (95% CI)		
Piper 躯体												
3	随机试验	严重 [a]	严重 [b]	不严重	不严重	无	115	114	-	MD **-2.01 SD** (-2.2 到 -1.82)	⊕⊕◯◯ 低	关键
Piper 情绪												
3	随机试验	严重 [a]	严重 [b]	不严重	不严重	无	115	114	-	MD **-1.96** (-2.07 到 -1.85)	⊕⊕◯◯ 低	关键
Piper 行为												
3	随机试验	严重 [a]	严重 [b]	不严重	不严重	无	115	114	-	MD **-1.59** (-1.71 到 -1.48)	⊕⊕◯◯ 低	关键
生活质量												
3	随机试验	严重 [a]	严重 [b]	不严重	不严重	无	99	98	-	MD **6.65** (4.31 到 8.99)	⊕⊕◯◯ 低	重要

CI: Confidence interval; **MD:** Mean difference

Explanations

a. 未报告盲法和或分配隐藏

b. 异质性较高

Q3：康艾注射液 compared to 西医常规治疗 for 癌因性疲乏

Certainty assessment							№；患者的		效果		Certainty	重要性
№；研究的	研究设计	偏倚风险	不一致性	间接性	精确性	其他考虑因素【注意事项】	[干预]	[对照]	相对 (95% CI)	绝对 (95% CI)		
疲劳量表评分												
6	随机试验	严重 [a]	严重 [b]	不严重	不严重	无	230	230	-	MD **-3.64** (-3.87 到 -3.41)	⊕⊕◯◯ 低	关键
QLQ-30 评分												
2	随机试验	严重 [a]	严重 [b]	不严重	不严重	无	85	85	-	MD **12.53**(11.32 到 13.73)	⊕⊕◯◯ 低	重要
骨髓抑制发生率												
2	随机试验	严重 [a]	严重 [b]	不严重	不严重	无	16/88 (18.2%)	35/88 (39.8%)	**比值比 0.34** (0.17 到 0.67)	**214 每 1,000** (来自 297 到 91)	⊕⊕◯◯ 低	重要

CI: Confidence interval; **MD:** Mean difference; **OR:** Odds ratio

Explanations

a. 未报告随机方法或分配隐藏或盲法

b. 异质性较高

Q4：参芪扶正注射液 compared to 西医常规治疗 for 癌因性疲乏

Certainty assessment	№；患者的	效果	Certainty	重要性

№研究的	研究设计	偏倚风险	不一致性	间接性	精确性	其他考虑因素【注意事项】	[干预]	[对照]	相对 (95% CI)	绝对 (95% CI)		
疲劳量表评分												
5	随机试验	严重 [a]	严重 [b]	不严重	不严重	无	253	233	-	MD **-1.66** (-1.81 到 -1.51)	⊕⊕◯◯ 低	关键
生活质量评分												
2	随机试验	严重 [a]	严重 [b]	不严重	不严重	无	83	80	-	MD **7.53** (5.35 到 9.7)	⊕⊕◯◯ 低	重要
临床总有效率												
2	随机试验	严重 [a]	严重 [b]	不严重	不严重	无	127/147 (86.4%)	85/126 (67.5%)	**比值比 3.07** (1.68 到 5.61)	**190 每 1,000** (来自 102 到 246)	⊕⊕◯◯ 低	重要

CI: Confidence interval; **MD:** Mean difference; **OR:** Odds ratio

Explanations

a. 未报告随机方法或盲法或分配隐藏

b. 异质性较高

Q5：参麦注射液 compared to 西医常规治疗 for 癌因性疲乏

Certainty assessment							№：患者的		效果		Certainty	重要性
№研究的	研究设计	偏倚风险	不一致性	间接性	精确性	其他考虑因素【注意事项】	[干预]	[对照]	相对 (95% CI)	绝对 (95% CI)		
疲劳发生率												
2	随机试验	严重 [a]	严重 [b]	不严重	不严重	无	47/143 (32.9%)	86/129 (66.7%)	**比值比 0.25** (0.15 到 0.42)	**333 每 1,000** (来自 436 到 210)	⊕⊕◯◯ 低	关键
生活质量评分												
2	随机试验	严重 [a]	严重 [b]	不严重	不严重	无	116	100	-	MD **5.97** (4.53 到 7.42)	⊕⊕◯◯ 低	重要
中医证候积分												
2	随机试验	严重 [a]	严重 [b]	不严重	不严重	无	87	89	-	MD **-3.2** (-3.45 到 -2.95)	⊕⊕◯◯ 低	重要

CI: Confidence interval; **MD:** Mean difference; **OR:** Odds ratio

Explanations

a. 未报告随机方式或盲法或分配隐藏

b. 异质性较高

Q6：艾迪注射液 compared to 西医常规治疗 for 癌因性疲乏

Certainty assessment	№：患者的	效果	Certainty	重要性

№；研究的	研究设计	偏倚风险	不一致性	间接性	精确性	其他考虑因素【注意事项】	[干预]	[对照]	相对 (95% CI)	绝对 (95% CI)		
疲劳量表评分												
3	随机试验	严重 [a]	严重 [b]	不严重	不严重	无	114	110	-	MD-**1.15**(-1.44 到 -0.87)	⊕⊕◯◯ 低	关键
生活质量评分												
3	随机试验	严重 [a]	严重 [b]	不严重	不严重	无	114	110	-	MD **9.16**(7.85 到 10.46)	⊕⊕◯◯ 低	重要
骨髓抑制发生率												
2	随机试验	严重 [a]	严重 [b]	不严重	不严重	无	18/90 (20.0%)	42/86 (48.8%)	**比值比 0.26** (0.13 到 0.51)	**290 每 1,000** (来自 378 到 161)	⊕⊕◯◯ 低	重要

CI: Confidence interval; **MD:** Mean difference; **OR:** Odds ratio

Explanations

a. 未报告盲法或分配隐藏

b. 异质性较高

Q7：针刺 compared to 西医常规治疗 for 癌因性疲乏

Certainty assessment							№；患者的		效果		Certainty	重要性
№；研究的	研究设计	偏倚风险	不一致性	间接性	精确性	其他考虑因素【注意事项】	[干预]	[对照]	相对 (95% CI)	绝对 (95% CI)		
针刺与标准/不干预改善癌因性疲乏量表评分												
7	随机试验	严重 [a]	严重 [b]	不严重	不严重	无	183	178	-	SMD **-1.25 SD**(-2.05 到 -1.45)	⊕⊕◯◯ 低	关键
针刺与假针刺改善癌因性疲乏量表评分												
4	随机试验	严重 [a]	严重 [b]	不严重	不严重	无	116	107	-	SMD **-0.28 SD** (-0.54 到 -0.01)	⊕⊕◯◯ 低	关键
4 周内针刺与标准/不干预改善癌因性疲乏量表评分												
8	随机试验	严重 [a]	严重 [b]	不严重	不严重	无	216	210	-	SMD **-0.95 SD**(-1.72 到 -0.18)	⊕⊕◯◯ 低	关键

CI: Confidence interval; **SMD:** Standardised mean difference

Explanations

a. 纳入研究未报告分配隐藏和盲法

b. 异质性较高

Q8：艾灸 compared to 西医常规治疗 for 癌因性疲乏

Certainty assessment							№；患者的		效果		Certainty	重要性
№；研究的	研究设计	偏倚风险	不一致性	间接性	精确性	其他考虑因素【注意事项】	[干预]	[对照]	相对 (95% CI)	绝对 (95% CI)		
Piper 疲乏量表评分改善												

9	随机试验	严重 [a]	严重 [b]	不严重	不严重	无	333	335	-	MD **-1.29** (-1.88 到 -0.7)	⊕⊕◯◯ 低	关键
KPS												
10	随机试验	严重 [a]	严重 [b]	不严重	不严重	无	354	360	-	MD **7.08** (3.31 到 10.85)	⊕⊕◯◯ 低	重要
QLQ-C30 生活质量												
5	随机试验	严重 [a]	严重 [b]	不严重	不严重	无	182	183	-	MD **9.88**(5.03 到 14.73)	⊕⊕◯◯ 低	重要

CI: Confidence interval; **MD:** Mean difference

Explanations

a. 纳入研究为报告分配隐藏和盲法

b. 异质性较高

Q9：耳穴 compared to 西医常规治疗 for 癌因性疲乏

Certainty assessment							№：患者的		效果		Certainty	重要性
№：研究的	研究设计	偏倚风险	不一致性	间接性	精确性	其他考虑因素【注意事项】	[干预]	[对照]	相对 (95% CI)	绝对 (95% CI)		
癌因性疲乏改善率												
5	随机试验	严重 [a]	严重 [b]	不严重	不严重	无	109/182 (59.9%)	61/181 (33.7%)	**比值比 1.76** (1.42 到 2.17)	**135 每 1,000** (来自 82 到 187)	⊕⊕◯◯ 低	关键
生活质量												
3	随机试验	严重 [a]	严重 [b]	不严重	不严重	无	109	106	-	MD **7.34** (5.11 到 9.57)	⊕⊕◯◯ 低	重要

CI: Confidence interval; **MD:** Mean difference; **OR:** Odds ratio

Explanations

a. 纳入研究未报告分配隐藏和盲法

b. 异质性较高

卵巢癌合并焦虑患者，中医药（中药、适宜技术）单用或者联合西医常规干预焦虑症状的疗效及安全性如何？

Q1：益气活血、疏肝补肾中药+常规化疗 compared to 常规化疗 for 卵巢癌合并焦虑

Certainty assessment							№：患者的		效果		Certainty	重要性
№：研究的	研究设计	偏倚风险	不一致性	间接性	精确性	其他考虑因素【注意事项】	中药+化疗VS化疗	placebo	相对 (95% CI)	绝对 (95% CI)		
SAS评分												

4	随机试验	严重[a]	严重[b]	不严重	严重[c]	无	134	134	-	SMD **1.48 更高** (1.2 更高到 1.76 更高)	⊕○○○ 极低	

CI：Confidence interval；**SMD**：Standardized Mean Difference；

Explanations

a 纳入的研究均未报告盲法及随机分配隐藏

b I^2比较大，超过50%

c 样本量不够400，可信区间太宽

Q2：传统功法+西医常规治疗 compared to 西医常规治疗 for 卵巢癌合并焦虑

Certainty assessment							№；患者的		效果		Certainty	重要性
№；研究的	研究设计	偏倚风险	不一致性	间接性	精确性	其他考虑因素【注意事项】	传统功法	placebo	相对 (95% CI)	绝对 (95% CI)		
SAS评分												
2	随机试验	严重[a]	严重[b]	不严重	严重[c]	无	97	97	-	SMD **1.59 更低** (1.92 更低到 1.26 更低)	⊕○○○ 极低	

CI：Confidence interval；**SMD**：Standardized Mean Difference；

Explanations

a 纳入的研究未报告随机分配隐藏

b I^2比较大，超过50%

c 样本量不够400，可信区间太宽

Q3：穴位按摩+西医常规治疗 compared to 西医常规治疗 for 卵巢癌合并焦虑

Certainty assessment							№；患者的		效果		Certainty	重要性
№；研究的	研究设计	偏倚风险	不一致性	间接性	精确性	其他考虑因素【注意事项】	穴位按摩	placebo	相对 (95% CI)	绝对 (95% CI)		
SAS评分												
2	随机试验	严重[a]	不严重	不严重	严重[b]	无	101	100	-	SMD **1.29 更低** (1.59 更低到 0.98 更低)	⊕⊕○○ 低	

CI：Confidence interval；**SMD**：Standardized Mean Difference；

Explanations

a 纳入的研究未报告随机分配隐藏和盲法

b 样本量不够 400，可信区间太宽

（七）推荐意见

1.推荐意见形成方法

将推荐意见的证据级分别推送至30位中医、西医、中西医结合肿瘤科专家，专家组成员基于证据总结、患者意愿、经济性分析与专临床经验，平衡推荐意见利弊之后，基于GRADE网格法对每条推荐意见的推荐等级进行评分，经过名义组法，获得专家推荐意见，如果超过60%的人数选择认可则作为条款通过。其余情况视为条款不通过。达成共识的前提下，如果证据等级为A、B，超过60%认可，则为推荐，证据等级为C，超过75%人数选择认可,也视为推荐，少于75%人数认可，视为考虑，证据等级为D，超过75%人数选择认可，视为可选。本指南中所有中医证候、症状、舌脉及治疗方药的推荐均按证据等级和专家推荐意见排序及采纳。

中医药临床指南及专家共识中不同干预措施的推荐意见核心报告内容

干预措施	内容1	内容2	内容3	内容4	内容5	内容6	内容7	内容8
方剂	方名	来源	药物组成	剂量	用法	加减法	疗程	注意事项
中成药	药名	来源a	药物组成b	用法用量c	疗程d	注意事项		
针刺(包括体针、头针、梅花针、电针等)	针刺类型	主穴	配穴	辨证/对症取穴	操作e	疗程d	注意事项	
灸法	灸法类型	主穴	配穴	手法	疗程b	加减法	注意事项	
拔罐	拔罐类型	取穴	操作e	疗程d	加减法	注意事项		
推拿	主穴	配穴	手法	疗程b	加减法	注意事项		
外治法(包括灌肠、熏洗、贴敷等)	药物组成	用法用量	疗程d	注意事项				

注:a.该药物涉及的方剂来源；b.国家保密配方除外；c.包括干预措施的具体给药途径、使用方法及剂量；d.包括用药、针刺、艾灸等干预措施的治疗时间、频次等；e.包括针刺、拔罐、艾灸等干预措施的具体操作方法，如进针、行针方法等。

2.推荐意见投票结果

基于指南前期的研究基础,对每个临床问题的证据总结形成“证据决策表”供专家组审阅，介绍内容包括“临床问题”、“推荐意见草案（含推荐强度与证据质量）”、“推荐意见说明”、“证据小结”、“证据情况（Meta分析结果、描述性分析、证据质量评价）”以及“患者偏好与价值

观”。此外，提供“推荐意见形成会会议手册”，介绍内容包括“指南背景与概况”、“专家组名单”、“指南制订流程”、“证据的检索、筛选与综合”、“名义组法”、“GRADE 证据分级与网格法”等，便于专家组回顾并熟悉指南，进一步确保推荐意见形成会议投票的可信度。

专家组成员基于证据总结、患者意愿、经济性分析与专家临床经验，平衡推荐意见利弊之后，基于GRADE网格法对每条推荐意见的推荐等级进行评分，通过两轮德尔菲法就推荐意见达成共识和推荐意见。对于认可率超过60%的认为达成共识，结合证据分级进行强推荐或弱推荐，对于临床实践中不可缺少但缺乏循证医学证据的一些中药方剂制定的中药措施，制定了专家问卷，并通过问卷调查和共识会议形成建议。

投票规则： 认可，不认可。

决定推荐意见的四个因素

因素	说明
证据质量	证据质量越高，越适合给予强推荐，反之亦然
利弊平衡	利弊间的差异越大，越适合给予强推荐，反之亦然
偏好与价值观	患者之间的偏好与价值观越趋同，越适合给予强推荐，反之亦然
成本	干预措施的花费越低，消耗的资源越少，越适合给予强推荐，反之亦然

本文件推荐意见和证据质量关系表

综合推荐等级 a	GRADE 证据级别	专家认可度
强推荐	A	专家认可度≥60%
	B	专家认可度≥60%
	C	专家认可度≥75%
弱推荐	C	60%≤专家认可度<75%
	D	专家认可度≥75%

a 参考 GRADE 证据等级标准，并结合专家认可度进行调整。无法进行 GRADE 证据评价、但专家认可度≥75%的条款综合推荐等级为弱推荐。

表 7 推荐意见投票结果表

序号	推荐条目	推荐方向强度的票数					投票轮数	是否达成共识
		↑↑	↑	／	↓	↓↓		
1	对于卵巢癌手术患者，口服中药汤剂(木香、厚朴、熟大黄、枳实、槟榔、陈皮、黄芪、枳壳、甘草)对于防治卵巢癌术后腹胀腹痛更具有优势	16	10	4	0	0	1	是
2	推荐使用内关、足三里、三阴交、	15	8	7	0	0	1	是

	合谷穴位按摩；中药大黄、厚朴、枳实、木香、槟榔、冰片、吴茱萸、白芥子用姜汁调和成汁穴位贴敷内关(双)、足三里、三阴交、中脘、上脘；针灸足三里、中脘、天枢、上巨虚；耳穴贴压大肠、小肠、胃、三焦							
3	对于卵巢癌术后患者，合并中医药干预对于防治伤口难愈更具有优势，应用清热解毒、益气活血、祛腐生肌等中药外治可有效改善伤口愈合率，缩短伤口愈合时间，应用较多的药物为大黄、芒硝、黄芪、康复新液、龙血竭、生肌玉红膏等。	5	15	10	0	0	1	是
4	对于卵巢癌术后患者，大黄芒硝外敷对于防治淋巴囊肿更具有优势	9	16	5	0	0	1	是
5	对于出现卵巢癌化疗后白细胞降低等不良反应的患者，可选用当归补血汤、四君子汤、肾气丸等方加减，单药黄芪、白术、人参、党参、茯苓、黄精、鹿角霜、山药、薏苡仁、女贞子均具有升高白细胞的作用；对于出现卵巢癌化疗后贫血的患者，可加用阿胶、黄芪、制首乌、当归、熟地、大枣、白芍、党参、人参、鹿茸等。对于血小板下降明显患者，可选用归脾汤、八珍汤等方剂，加用黄芪、仙鹤草、鸡血藤、鹿角胶等。	22	8	0	0	0	2	是
6	贞芪扶正颗粒、复方皂矾丸、芪胶升白胶囊、地榆升白片、复方阿胶浆、生血宝颗粒能治疗骨髓抑制。	17	18	0	0	0	1	是
7	对于卵巢癌化疗后出现骨髓抑制的患者，隔姜灸大椎、膈俞、脾俞、胃俞、肾俞穴、直接灸神阙、气海、关元、足三里、针刺足三里、三阴交、血海、肾俞，（均双侧取穴）、穴位注射足三里穴能有效防治化疗后白细胞下降	17	11	2	0	0	1	是
8	对于卵巢癌化疗后出现骨髓抑制的患者，穴位注射足三里穴能有效防治化疗后白细胞下降	11	2	7	0	0	1	是
9	对于出现卵巢癌围化疗期恶心呕吐、腹泻等消化道不良反应的患者，旋覆代赭汤、丁香柿蒂汤、香砂六君子汤对于防治卵巢癌化	4	13	13	0	0	2	是

	疗后呃逆、恶心呕吐等消化道不良反应具有优势							
10	穴位贴敷、针刺、电针、耳穴贴压、艾灸和穴位注射可以改善卵巢癌化疗时消化道不良反应。	22	8	0	0	0	1	是
11	在卵巢癌化疗期，合并穴位针刺治疗对于改善化疗后周围神经损伤具有优势	12	9	9	0	0	1	是
12	减少化疗导致的神经毒性方面，推荐合并应用口服补阳还五汤、黄芪桂枝五物汤加减	8	16	6	0	0	1	是
13	在卵巢癌化疗期，合并黄芪桂枝五物汤泡洗治疗对于改善化疗后周围神经损伤具有优势	9	11	8	2	0	1	是
14	在卵巢癌化疗期，推荐合并四君子汤合七宝美髯丹加减改善化疗后脱发。加减药物主要以补益肝肾为主，主要包括：枸杞子、制何首乌、当归、桑椹、墨旱莲、女贞子等。	11	16	3	0	0	1	是
15	推荐合并头皮外用降温冰帽对于改善化疗后脱发更具有优势	10	19	6	0	0	1	是
16	卵巢癌维持治疗口服复方斑蝥胶囊、西黄胶囊、静脉给予艾迪注射液、康艾注射液、复方苦参注射液、参芪扶正注射液、参麦注射液在卵巢癌维持治疗中更具有优势，主要体现在提升患者生存质量、降低毒副反应等方面	21	8	1	0	0	2	是
17	冲任失调证以理冲汤加减为主	12	8	8	2	0	1	是
18	气滞血瘀证以加味乌药散合桂枝茯苓丸加减为主，寒凝血瘀证以附子理中汤合三棱煎加减为主，阳虚水泛证以真武汤加减为主，瘀毒互结证以大七气汤加减为主	18	12	0	0	0	2	是
19	合并使用穴位贴敷、针刺、耳穴压豆、太极拳和气功对于控制高血压具有优势。	11	15	4	0	0	1	是
20	合并使用天麻钩藤饮、半夏白术天麻汤、杞菊地黄丸、清肝降压片、银杏叶滴丸对于控制高血压具有优势。	12	8	6	4	0	1	是
21	使用血管抑制剂靶向治疗的卵巢癌患者，中药外洗（当归、丹皮、紫草、黄芪、鸡血藤、金银花、大黄、生地、威灵仙、甘草）对于防治血管抑制剂靶向药物治疗	23	7	0	0	0	1	是

	期间发生的手足综合征具有优势							
22	可以考虑应用康复新液外洗；应用灸法（合谷、三阴交、太冲、督脉）防治血管抑制剂靶向药物治疗期间发生的手足综合征	7	12	10	1	0	1	是
23	对于卵巢癌患者，合并中医药（中药、中医适宜技术）对防治癌因性疲乏更具有优势。推荐中药汤剂：人参养荣汤、补中益气汤；适宜技术推荐针刺足三里、三阴交、合谷、气海、太溪；艾灸：足三里、大椎、关元、 气海、三阴交；使用耳穴压豆或磁珠耳部肝、脾、胃、神门、皮质下、交感神经穴位	17	10	3	0	0	1	是
24	推荐使用中药注射液康艾注射液、参芪扶正注射液，也可以考虑参麦注射液、艾迪注射液防治癌因性疲乏	11	9	10	0	0	1	是
25	对于卵巢癌合并焦虑患者，中药汤剂、传统功法、耳穴疗法、穴位按摩对于防治焦虑症状具有优势。	12	13	5	0	0	1	是

（八）撰写指南草案

指南草案执笔人：卢雯平、田小飞、田建辉、白萍、肖静、冯利、许云、岑尧、范秀华、康山、韩凤娟、宋恩峰，完成时间 2022 年 8 月。

其他指南起草组成员提出如下修改意见：

1.本指南撰写的核心要义是实用性，进而达到指导中、西医医生管理患者的目的，撰写内容应有亮点，突出中西医结合的特点；

2.晚期卵巢癌诊断方面内容较为单薄，可进行补充。诊断中肿瘤标志物可补充 HE4 和罗马指数；

3.鉴别诊断内容应补充“卵巢囊肿”与“卵巢癌”的鉴别，“生殖器结核”应补充体格检查的内容；

4.病理学分期部分应放入附表内；

5.明确“围化疗期”的定义以及出处；

6.西医全程治疗的手术内容应补充术前评估的内容，“手术步骤”改为“手术要点”更为恰当，晚期上皮性卵巢癌新辅助化疗后间歇性减瘤术内容中新辅助化疗次数和用药还应明确，姑息手术内容还应更为详实；

7.本方案西医内容应参考《NCCN 肿瘤临床实践指南（2022 版）-卵巢癌》、中国临床肿瘤学会《中国临床肿瘤学会卵巢癌诊疗指南（2022）》编写；

8.多囊卵巢综合症与晚期卵巢癌发病关系不大，可进行删减；

9.维持治疗内容应统一各部分写作风格，可采用图表方式展示；

10.围手术期不良反应补充术后淋巴囊肿的内容，将术后疲乏和癌性疲乏进

行合并；靶向治疗期不良反应补充手足综合征的内容；

11.慢病周期管理中医维持治疗部分和围手术期不良反应部分应简洁、易懂，写明证型、主症、方剂、加减化裁、中成药，以该形式进行撰写。补充中医药姑息治疗的内容；

12.参考文献应精简，并在全文后列出。

（九）指南草案的质量评价及适用性评价

1.质量评价

对本指南进行质量评价的专家如下：

序号	姓名	单位	学历	职称
1	王建六	北京大学人民医院	博士	主任医师
2	李斌	中国医学科学院肿瘤医院	博士	主任医师
3	岑尧	内蒙古自治区人民医院	硕士	主任医师
4	程志强	中日友好医院	博士	主任医师
5	陈薇	北京中医药大学	博士	研究员
6	冯利	中国医学科学院肿瘤医院	博士	主任医师
7	范秀华	中国中医科学院广安门医院	博士	主任医师
8	郭中宁	中国中医科学院西苑医院	博士	主任医师
9	韩凤娟	黑龙江中医药大学附属第一医院	博士	主任医师
10	康山	河北医科大学第四医院	博士	主任医师
11	李鹤	上海仁济医院	硕士	副主任医师
12	李占林	河北北方学院附属第一医院	硕士	主任医师
13	段微	北京妇产医院	博士	主任医师
14	孔为民	北京妇产医院	博士	主任医师
15	邱瑞瑾	北京中医药大学东直门医院	博士	副研究员
16	綦惠娟	赤峰学院附属医院	博士	主任医师
17	孙长岗	潍坊医学院附属医院	博士	主任医师
18	田建辉	上海市中医医院	博士	主任医师
19	田小飞	陕西省肿瘤医院	博士	主任医师
20	肖静	广东省中医院	博士	主任医师
21	吴心力	黑龙江省中医医院	博士	主任医师
22	许云	中国中医科学院西苑医院	博士	副主任医师
23	薛冬	北京大学肿瘤医院	博士	主任医师
24	杨英捷	贵州医科大学附属医院	博士	主任医师
25	应小燕	南京医科大学第二附属医院	博士	主任医师
26	田劭丹	北京中医药大学东直门医院	硕士	主任医师
27	张青	北京中医医院肿瘤科	博士	主任医师
28	赵瑞华	中国中医科学院广安门医院	博士	主任医师
29	张曦文	中国中医科学院广安门医院	博士	主治医师

质量评价结果，见表8。

表 8 指南质量评价结果

序号	条目内容	选择人数		
		是	否	不适用
1	指南制订小组由包含临床专家和方法学家在内的多学科团队组成	29	0	0
2	指南制订人员与指南内容无利益冲突	29	0	0

3	有构建清楚的临床问题	27	2	0
3.1	报告了中医病名或西医病名或具体中医证候	29	0	0
3.2	报告了干预措施的具体类型如汤药、中成药、针灸等	29	0	0
3.3	对照措施合理	28	1	0
3.4	结局指标是具有临床重要性，或能体现中医药治疗优势的指标	27	2	0
4	检索范围全面	20	0	0
4.1	检索内容包括了中医古籍文献与现代临床研究文献	29	0	0
4.2	报告了检索的数据库、检索时间、检索词	29	0	0
4.3	提供了代表数据库的具体检索策略	29	0	0
5	提供了纳入排除标准，并与临床问题相符	29	0	0
6	描述了文献筛选过程，并提供了清晰的筛选流程图	29	0	0
7	提供了排除文献列表	29	0	0
8	数据提取过程清晰	29	0	0
9	提供了纳入文献清单及纳入文献特征表	29	0	0
10	数据综合过程正确	29	0	0
10.1	效应值选择正确	29	0	0
10.2	统计分析方法正确	29	0	0
11	选用了国际或行业内公认的证据质量评价方法，且证据质量评价过程正确，前后无矛盾	29	0	0
12	提供了证据概要表	29	0	0
13	明确描述形成推荐意见的考虑要素	29	0	0
14	明确解释推荐强度的含义	29	0	0
15	明确描述形成推荐意见的方法，并提供了相关附件如调研问卷或会议记录	29	0	0
16	每条推荐意见均有证据支持	29	0	0

2.适用性评价

对适用性评价的主要结果进行总结，同时以表格形式汇总指南的适用性评价结果，见表9。

表 9 指南适用性评价结果

序号	条目	选择人数		
		是	否	不适用
领域1. 总体				
1	制定的机构组织及成员具有权威性	29	0	0
2	明确定义指南使用人群（中医医师/中西医结合医师/西医医师等）	29	0	0
3	明确定义指南适用环境（三级医院/二级医院/社区诊疗中心等）	29	0	0
4	指南内容全面	29	0	0
5	理、法、方、药一致	27	2	0
领域2. 清晰性				
1	推荐建议易于识别（在框中加粗，粗体文字，下划线等）	29	0	0
2	推荐意见表达用词明确，并列出每项推荐意见的证据等级	29	0	0
3	列出指南内包含的所有术语和英文译名，及其具体定义	29	0	0
4	指南中的临床问题明确，且与推荐意见前后一致	29	0	0
领域3. 可执行性				
1	指南使用人员可以理解指南内容	29	0	0

2	明确定义患者人群特征，必要时应列出不适用的亚组人群	29	0	0
3	疾病的病因清晰，有依据，并得到行业认同	29	0	0
4	疾病的病机清晰，有依据，并得到行业认同	29	0	0
5	中医常见证候清晰，有依据，并得到行业认同	29	0	0
6	对于推荐的方药，明确描述了具体组方	29	0	0
6.1	报告了方剂名称；	29	0	0
6.2	报告了方剂来源；	29	0	0
6.3	报告了方剂组成及每味中药的克数；	29	0	0
6.4	报告了用药方案；	29	0	0
6.5	报告了煎煮法（需要时列出）；	29	0	0
6.6	报告了加减用药方案（需要时列出）；	29	0	0
6.7	报告了注意事项	29	0	0
6.8	如果有合并治疗，描述合并治疗方案	29	0	0
6.8.1	合并治疗类型	29	0	0
6.8.2	合并治疗时机	29	0	0
6.8.3	合并治疗剂量/频次	29	0	0
6.8.4	合并治疗疗程	29	0	0
6.9	明确描述该方剂改善的结局	29	0	0
7	对于中成药，明确描述了下列信息			
7.1	报告了用药方案；	29	0	0
7.2	报告了疗程；	26	3	0
7.3	报告了注意事项	29	0	0
7.4	如果有合并治疗，描述合并治疗方案	29	0	0
7.4.1	合并治疗类型	29	0	0
7.4.2	合并治疗时机	29	0	0
7.4.3	合并治疗剂量/频次	29	0	0
7.4.4	合并治疗疗程	29	0	0
7.5	明确描述该中成药改善的结局	28	1	0
7.6	该中成药是否属于医保药物或基药	25	5	0
8	对于非药物疗法（如针刺，推拿等），提供足够详细信息，以允许临床医师可以进行相关操作	29	0	0
8.1	针刺			
8.1.1	报告了针刺的穴位	29	0	0
8.1.2	报告了针刺的深度	29	0	0
8.1.3	报告了针刺的刺激方式	29	0	0
8.1.4	报告了留针时间	29	0	0
8.1.5	报告了治疗频次	29	0	0
8.1.6	报告了疗程	29	0	0
8.1.7	必要时报告联用的其他干预措施	29	0	0
8.1.8	明确描述该疗法改善的结局	29	0	0
8.2	灸法			
8.2.1	报告了灸法的适用情况	29	0	0
8.2.2	报告了某灸法的操作要点	29	0	0
8.2.3	报告了治疗频次	29	0	0
8.2.4	报告了灸法的疗程	29	0	0
8.2.5	明确描述该疗法改善的结局	29	0	0
8.3	推拿			
8.3.1	报告了推拿手法	0	0	29
8.3.2	报告了推拿时间	0	0	29

8.3.3	报告了治疗频次	0	0	29
8.3.4	报告了疗程	0	0	29
8.3.5	明确描述该疗法改善的结局	0	0	29
8.4	针刀疗法			
8.4.1	报告了无菌操作要点	0	0	29
8.4.2	报告了进针的取穴部位	0	0	29
8.4.3	报告了进针的深度	0	0	29
8.4.4	报告了进针手法的操作要点	0	0	29
8.4.5	报告了治疗频次	0	0	29
8.4.6	报告了疗程	0	0	29
8.4.7	必要时报告联用的其他干预措施（如推拿）	0	0	29
8.4.8	明确描述该疗法改善的结局	0	0	29
8.5	敷贴、熏洗			
8.5.1	报告了贴敷片剂治疗的部位或熏洗的部位	29	0	0
8.5.2	报告了治疗频次	29	0	0
8.5.3	报告了疗程	29	0	0
8.5.4	必要时报告联用的其他干预措施	29	0	0
8.5.5	明确描述该疗法改善的结局	29	0	0
8.6	耳穴			
8.6.1	报告了耳穴刺激的穴位	29	0	0
8.6.2	报告了治疗频次	29	0	0
8.6.3	报告了疗程	29	0	0
8.6.4	必要时报告联用的其他干预措施	29	0	0
8.6.5	明确描述该疗法改善的结局	29	0	0
8.7	传统功法（太极、气功等）	29	0	0
8.7.1	报告了具体功法的名称	29	0	0
8.7.2	报告了练功的频次与时长	29	0	0
8.7.3	报告了练功的注意事项	29	0	0
8.8	其他非药物疗法			
9	必要时可针对性提出预防调护的措施	29	0	0
10	必要时可针对性提出康复调摄的措施	29	0	0

3.评价结果分析

分析记录质量评价和适用性评价结果，根据其结果，修改完善指南草案，形成征求意见稿。

（十）征求意见

2022年9月11日，以召开会议的形式邀请了来自20家单位的29位专家对《卵巢癌中西医结合诊疗方案》进行广泛征求意见。专家涉及11个地区（北京、上海、广东、山东、内蒙古、黑龙江、河北、陕西、贵州、江苏、甘肃），以中医肿瘤学、肿瘤学、妇科学、妇科肿瘤学为主，24名主任医师，2名副主任医师，1名研究员，1名副研究员，1名主治医师。

将收到的反馈意见归纳汇总和研究处理，给出“采纳”“部分采纳”或“未采纳”的处理意见，汇总形成意见汇总处理表。对于“未采纳”和“部分采纳”的反馈意见，应当说明理由。见表10。

表10 征求意见汇总处理表

序号	章条编号	草案内容	提出单位和姓名	反馈意见内容及理由	意见处理情况
1	4.5	诊断及鉴别诊断、卵巢癌的西医治疗	北京大学人民医院 王建六	西医诊断和治疗部分需要精简	采纳
2	整体	整体框架	北京大学人民医院 王建六、首都医科大学附属北京中医医院 徐咏梅、北京中医药大学东直门医院 田劭丹	修改框架，先描述诊断后描述治疗	采纳
3	6.1.1	腹胀腹痛	中国医学科学院肿瘤医院 李斌	改为肠梗阻	采纳
4	6.2	化疗后不良反应的中医治疗	中国医学科学院肿瘤医院 李斌	靶向治疗的不良反应中医治疗也应进行推荐	采纳
5	整体	晚期卵巢癌的中医治疗	北京中医药大学东方医院	补充晚期卵巢癌腹水的中医治疗	采纳
6	整体	推荐意见	中国医学科学院肿瘤医院 冯利	证据等级和推荐意见的关系需要说明	部分采纳，在编制说明中说明
7	整体	证型	首都医科大学附属北京中医医院 张青	中成药的分证型使用需要在临床表现中体现	采纳
8	5.1	卵巢癌分期	陕西省肿瘤医院 田小飞	而对于一些Ⅰ期粘液性癌、高分化子宫内膜样癌、低级别浆液性癌无需治疗，明确为 IA/IB 期	采纳
9	整体	添加内容	陕西省肿瘤医院 田小飞	建议添加中医治未病的内容	未采纳，本指南为诊断和治疗指南，有单独的治未病指南
10	6.1.1	肠梗阻的中医适宜技术疗法	广东省中医院 肖静	肠梗阻保留灌肠需要说明“肛门、结直肠手术后禁用”	采纳
11	整体	推荐意见的顺序	广东省中医院 肖静	建议将推荐级别高的治疗措施写在前面，较低的写在后面	采纳
12	整体	临床问题	首都医科大学附属北京中医医院 徐咏梅	修改临床问题表述，使 PICO 更清晰	采纳
13	整体	中成药推荐	首都医科大学附属北京中医医院 徐咏梅	有超说明书用药的问题，需要修改	采纳
14	整体	饮片	中国中医科学院西苑医院 郭中宁	炮制方法、煎服法需要说明	采纳
15	整体	检索流程图	北京中医药大学 陈薇	编制说明中检索流程图不能包括后续证据评价	采纳

				内容	
16	整体	质量评价	北京中医药大学 陈薇	草案中不需要展示纳入文献的质量评价等级	采纳
17	整体	临床问题	北京中医药大学 陈薇	临床问题“防治”改为“治疗”	采纳
18	整体	GRADE 评级	北京中医药大学 陈薇	写明获得 GRADE 评级的结局指标为何	采纳
19	整体	推荐意见	北京中医药大学 陈薇	推荐意见需要考虑证据等级	采纳
20	整体	推荐意见	北京中医药大学东直门医院 邱瑞瑾	展示获得 GRADE 评价具体的结局指标、效应量和级别	采纳
21	整体	中西医结合方式	中国医学科学院肿瘤医院 李斌、北京妇产医院 孔为民、北京妇产医院 段微、河北北方学院附属第一医院 李占林、内蒙古自治区人民医院 岑尧	说明中西医结合的时机	部分采纳，在本指南的治疗部分 6.1、6.2 和 7 明确提出了中西医结合的时机
22	6.1.3	淋巴囊肿	内蒙古自治区人民医院 岑尧、黑龙江省中医医院 吴心力	建议补充如意金黄散	未采纳，如意金黄散证据较少，前期未能达成专家共识
23	整体	临床症状	中国中医科学院广安门医院 赵瑞华	症状描述直白些会更好	采纳
24	附录	添加内容	北京妇产医院 段微	中药与 PARP 抑制剂的药物相互作用要说明	未采纳，已在附录 E 中对该问题进行了详细说明

（十一）送审

记录提交审查的时间，标准化办公室形式审核意见及处理情况。记录审查会议的情况，包括会议时间、评审专家、评审意见和意见处理情况。

四、与国内外同类指南的对比和最新指南采用情况

目前无已发布的中西医结合卵巢癌指南。

本指南引用了 NCCN 肿瘤临床实践指南（2022 年第 4 版）《卵巢癌（包括输卵管癌和原发性腹膜癌）》（NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology Version 4.2022 《Ovarian Cancer Including Fallopian Tube Cancer and Primary Peritoneal Cancer》OV-7 和中国临床肿瘤学会《卵巢癌诊疗指南（2022）》第 8 章的内容。

五、与现行强制性国家标准或政策法规的关系

与现行强制性国家标准及政策法规无矛盾或冲突。

六、代表性分歧意见的处理经过和依据

整个编制过程中无代表性的重大分歧意见。

七、宣传、贯彻指南和后效评价指南的要求和措施

（一）宣传、贯彻指南的措施

1. 指南的实施单位

中国中医科学院广安门医院、北京大学人民医院、上海中医药大学附属市中医医院、中国医学科学院肿瘤医院、广东省中医院、首都医科大学附属北京中医医院、陕西省肿瘤医院、北京中医药大学、北京中医药大学附属东直门医院、北京大学肿瘤医院、中国中医科学院西苑医院、首都医科大学附属北京妇产医院、潍坊医学院中医学院、内蒙古自治区医院、黑龙江中医药大学附属第一医院、河北医科大学第四医院、上海交通大学医学院附属仁济医院、贵州省肿瘤医院、南京医科大学第二附属医院、赤峰学院附属医院。

2. 其他宣传、贯彻本指南的措施

由国家中医药管理局统一组织行业内的推广和贯彻工作；举办指南应用推广培训班、继续教育培训班；利用中华中医药学会肿瘤分会平台，在其开展的学术活动中介绍；在相关杂志、网站发表文章 1-2 篇。

（二）指南的用户评价

指南发布一年内完成用户报告。

（三）指南的修订

按照目前国际上发布的指南更新报告规范进行更新。更新周期在2-5年之间，决定是否启动更新程序的因素包括：文件发布后是否有新的相应的证据出现，证据变化对诊疗方案推荐意见的影响，及诊疗方案推荐意见的强度是否发生变化。

八、废止现行有关指南的建议

不涉及。

九、相关附录

（一）调研问卷

1.您对于既往中医药治疗卵巢癌相关指南/专家共识是否关注?它们对您的临床决策是否有所帮助?您在什么情况时会选择查阅指南或共识?

2.和西医指南相比，在可接受性，可读性，可获取性和可行性方面，你认为目前已有的中医指南或共识有哪些不足之处?

3.对于您目前了解的临床指南或共识，您觉得限制您在临床使用它们的因素有哪些?(指南或共识适用范围，术语的使用，诊断要点是否明确，证候分类、治则、组方用药是否合理，是否足够细化，足以起到示范作用?其他治法和调摄预防是否合理?

4.目前已有的本专业相关的指南或共识在疗效，安全性，经济性，简便性，以及规范医疗管理和保障医疗服务方面有哪些优点，又有哪些不足之处?

5.您认为《卵巢癌中西医结合诊疗方案》应该注重哪几个方面?

6.除指南或共识外，您或临床中接诊的患者希望在卵巢癌治疗的何种阶段使用中药？

7.对于本文件《卵巢癌中西医结合诊疗方案》所解决的临床问题，您希望涉及哪些方面？

（二）历次会议纪要

1.启动会：

时间：2020 年 9 月 13 日 9:00-11:30

地点：线上会议

参加人员：

中国中医科学院广安门医院卢雯平教授，中国中医科学院广安门医院朴炳奎教授，北京大学人民医院王建六教授，广州中医药大学第一附属医院林丽珠教授，中国医学科学院肿瘤医院白萍教授；执笔专家（按姓氏拼音排序）：内蒙古自治区医院岑尧教授、北京中日友好医院程志强教授、中国中医科学院广安门医院范秀华教授、中国医学科学院肿瘤医院冯利教授、黑龙江中医药大学附属第一医院韩凤娟教授、河北医科大学第四医院康山教授、内蒙古赤峰学院附属医院綦惠娟教授、上海中医药大学附属龙华医院田建辉教授、陕西省肿瘤医院田小飞教授、广东省中医院肖静教授、黑龙江省中医药科学院吴心力教授、北京大学肿瘤医院薛冬教授、中国中医科学院西苑医院许云教授、南京医科大学第二附属医院应小燕教授、贵州省肿瘤医院杨英捷教授，北京中医医院张青教授，中国中医科学院广安门医院赵瑞华教授，学生代表、企业代表列席。

会议由卢雯平教授主持。

卢雯平教授主持开场，她首先对大家的莅临参会表示衷心的感谢和热烈的欢迎，并依次介绍了参会专家。卢教授谈到《卵巢癌中西医结合诊疗方案》的撰写意义重大，制订的原则是基于循证、可读性强和中西医结合。力求对使用《方案》的中、西医师具有指导作用。希望各位执笔专家认真撰写，编纂一部有切实临床意义的文件。

林丽珠教授对本文件进行了介绍，本文件由中国中医科学院广安门医院提出，中华中医药学会归口管理。由各位执笔专家撰写草案，广泛征求意见后形成征求意见稿，根据意见修改后形成送审稿，之后送审发布。

田建辉教授对《卵巢癌中西医结合诊疗方案》前期临床调研和调查问卷得到的撰写框架进行介绍，包括中西医的诊断思路，围手术期不良反应（伤口不愈合、肠梗阻（肠粘连）、淋巴囊肿）中医药管理、西药全身系统治疗（包括化疗、靶向治疗）相关不良反应（消化道反应、骨髓抑制、周围神经病变、脱发、高血压、手足皮肤不良反应）的中医药管理、晚期卵巢癌的中医辨病辨证维持治疗及卵巢癌伴随焦虑、癌因性疲乏的中医管理。

工作组组长为各位执笔专家介绍了各部分内容的检索过程、检索结果、证据评价结果和证据描述，之后为各位与会专家发放推荐意见征询表进行第一轮 Delphi 法，会后由工作组收集所有表格。

之后由各位执笔专家进行提问，由卢雯平教授进行一一解答。

会议主持及主席最后总结到，本次启动会高效、务实，达到了会议预期。《方案》内容不在多，而在于精。请各位专家根据循证结果和会后发送的 Delphi 结果进行撰写，如果第一轮未能达成共识，后续还会请大家再次填写表格，感谢大家的配合，相信各位参编专家在此次启动会后一定会顺利产出各部分内容。

2.第一次定稿会：

时间：2020 年 11 月 28 日 16:00-18:30

地点：北京国际饭店一层第六会议室

参加人员：

中国中医科学院广安门医院卢雯平教授，北京大学人民医院王建六教授，广州中医药大学第一附属医院林丽珠教授，中国医学科学院肿瘤医院白萍教授，首都医科大学附属北京妇产医院段微教授；执笔专家（按姓氏拼音排序）：内蒙古自治区医院岑尧教授、北京中日友好医院程志强教授、中国中医科学院广安门医院范秀华教授、中国医学科学院肿瘤医院冯利教授、黑龙江中医药大学附属第一医院韩凤娟教授、河北医科大学第四医院康山教授、内蒙古赤峰学院附属医院綦惠娟教授、上海中医药大学附属龙华医院田建辉教授、陕西省肿瘤医院田小飞教授、广东省中医院肖静教授、黑龙江省中医药科学院吴心力教授、北京大学肿瘤医院薛冬教授、中国中医科学院西苑医院许云教授、南京医科大学第二附属医院应小燕教授、贵州省肿瘤医院杨英捷教授，北京中医医院张青教授，学生代表、企业代表列席。

会议由卢雯平教授主持。

卢雯平教授主持开场，她首先对大家的莅临参会表示衷心的感谢和热烈的欢迎，并依次介绍了参会专家。卢教授简要回顾了《方案》的编写背景和写作历程。经过近 2 个月的努力，各位专家均交来了初稿，今天的会议将做进一步讨论，目的是统一编写原则和风格，修改初稿内容，为定稿做准备。

王建六教授在致辞中谈到，初稿内容详实，虽然还有一些内容需要继续斟酌讨论和修改完善，但本身已经非常有意义，起到沟通中、西医的媒介作用，沟通有无，最终起到减少患者病痛，使患者得到更完善的中西医治疗的作用。期待在大家的共同努力下，共识可以早日发表，惠及更多患者。

随即，各位执笔专家依次按章节介绍了初稿，纷纷就初稿内容发表了自己的看法和理解，现场气氛十分热烈。将其整理如下：

1.本文件撰写的核心要义是实用性，进而达到指导中、西医医生管理患者的目的，撰写内容应有亮点，突出中西医结合的特点；

2.晚期卵巢癌诊断方面内容较为单薄，可进行补充。诊断中肿瘤标志物可补充 HE4 和罗马指数；

3.鉴别诊断内容应补充“卵巢囊肿”与“卵巢癌”的鉴别，“生殖器结核”应补充体格检查的内容；

4.病理学分期部分应放入附表内；

5.明确“围化疗期”的定义以及出处；

6.西医全程治疗的手术内容应补充术前评估的内容，“手术步骤”改为“手术要点”更为恰当，晚期上皮性卵巢癌新辅助化疗后间歇性减瘤术内容中新辅助化疗次数和用药还应明确，姑息手术内容还应更为详实；

7.本文件西医内容应参考最新指南或共识编写；

8.多囊卵巢综合症与晚期卵巢癌发病关系不大，可进行删减；

9.维持治疗内容应统一各部分写作风格，可采用图表方式展示；
10.围手术期不良反应补充术后淋巴囊肿的内容，将术后疲乏和癌性疲乏进行合并；靶向治疗期不良反应补充手足综合征的内容；
11.慢病周期管理中医维持治疗部分和围手术期不良反应部分应简洁、易懂，写明证型、主症、方剂、加减化裁、中成药，以该形式进行撰写。补充中医药姑息治疗的内容；
12.参考文献应精简，并在全文后列出。
会议主持及主席最后总结到，本次定稿讨论会高效、务实，达到了会议预期。《方案》撰写的核心要义是要强调实用性，使中、西医的精华都得到很好的结合。要提纲挈领，重点突出，内容精炼，字斟句酌。相信各位参编专家根据此次会议讨论修改意见，修改完善，一定会顺利产出这部兼具学术指导意义和临床实用价值的《方案》，真正惠及广大医务工作者和患者。
2.第二次定稿会
时间：2022 年 9 月 11 日 9:30-12:00
地点：腾讯会议
参加人员：

中国中医科学院广安门医院卢雯平教授，北京大学人民医院王建六教授，中国医学科学院肿瘤医院李斌教授，首都医科大学附属北京妇产医院段微教授，内蒙古自治区医院岑尧教授、北京中医药大学陈薇教授、中国中医科学院西苑医院苏祥飞教授，北京中日友好医院程志强教授、中国中医科学院广安门医院范秀华教授、中国医学科学院肿瘤医院冯利教授、中国中医科学院西苑医院郭中宁教授，北京妇产医院孔为民教授，黑龙江中医药大学附属第一医院韩凤娟教授，内蒙古赤峰学院附属医院綦惠娟教授、上海中医药大学附属龙华医院田建辉教授、陕西省肿瘤医院田小飞教授、广东省中医院肖静教授、黑龙江省中医药科学院吴心力教授、北京大学肿瘤医院薛冬教授、中国中医科学院西苑医院许云教授、南京医科大学第二附属医院应小燕教授、贵州省肿瘤医院杨英捷教授，北京中医医院张青教授，北京中医医院徐咏梅教授，北京中医药大学东直门医院田劭丹教授，潍坊医学院中医学院孙长岗教授，上海仁济医院李鹤教授，河北北方学院第一附属医院李占林教授，北京中医药大学东方医院李泉旺教授，中国中医科学院广安门医院赵瑞华教授，中国中医科学院广安门医院张曦文主治医师，学生代表、企业代表列席。

会议由卢雯平教授和李斌教授主持。

卢雯平教授主持开场，她首先对大家的莅临参会表示衷心的感谢和热烈的欢迎，并依次介绍了参会专家。卢教授简要回顾了《方案》的编写背景和写作历程。

王建六教授在致辞中谈到，草案内容详实，超出预期，前期做了很多的工作，付出了很多心血。期待在大家的共同努力下，《方案》可以早日发布，惠及更多患者。

之后，由卢雯平教授为专家介绍《卵巢癌中西医结合诊疗方案》的主要内容，编写秘书组长吴晓晴为专家介绍《卵巢癌中西医结合诊疗方案编制说明》。各专家就《方案》和《编制说明》依次发表见解，气氛非常热烈，将其整理如下：

一、针对卵巢癌的中西医治疗原则进行讨论

田建辉：晚期卵巢癌死亡率极高，重视中西医结合治疗，

王建六：西医部分内容大量删减，整个框架需要先诊后治，超出预期，内容写的很好，中医具体方案很清楚，推荐级别需要好好斟酌。

李斌：西医部分需要哪一些方面需要中医介入这一部分需要明确，同时肠梗阻的问题需要考虑；淋巴漏手术后都会出现，是否还需要单独提出？骨髓抑制等化疗副作用是否全部归纳起来？

孔为民：不良反应可以再加入西医的内容，西医的中成药推荐需要明确什么时期使用，耐药、难治性卵巢癌中医可以在这部分作为亮点，循证医学证据等级需要加上

二、临床问题讨论

李泉旺：不全性肠梗阻的内容可以加一些，腹水比较好的方法也可以体现出来

冯利：强弱推荐有一个比较显著的说明；同时可以引用自己团队癌痛的一个指南内容

段微：靶向治疗副反应中医管理的内容多添加一些

薛冬：13 个问题的结构需要重新编排一下，特色部分内容需要再添加一些

范秀华：提倡做大样本量研究

张青：中医治疗的副作用也可以提一下

赵瑞华：中医的症状更简要一些

岑尧：什么时机干预中医中药希望更明确一些

田小飞：分期要明确等小细节需要注意下，中医方案希望便捷一些，康复阶段需要补充？

肖静：鉴别诊断需要添加，中医病名的书写（卵巢恶性肿瘤），腹胀腹痛肠梗阻可以放在一起，临床问题的排序可以按照临床实际排序，增加专家推荐意见，补充外治的方法。

吴心力：强调外治的方法。

郭中宁：第 5 条消化道反应便秘的情况，还有腹泻的症状可以强调更好的发挥一下；同时生附子等中药需要再注意下

田邵丹：层次需要更清晰更分明一些

徐咏梅：药物使用超说明书使用的地方需要注意一下

李占林：对于基层中医的大夫来说有很好的参考意见

陈薇：对于各个内容证据评价前不需要特定的评价；按照学会的技术内容进行报告；临床问题还需要修改，比如防还是治需要更明确一些；推荐的等级需要修改，在什么情况下选择用强推荐还需要进行筛选；证据评价证据 B 类证据比较少；证据质量和推荐级别还是需要互相参考的；不同结局指标评价需要再看下

邱瑞瑾：对不同的结局指标需要都展示一下。

会议主持及主席最后总结到，本次定稿讨论会高效完成了会议目标。感谢各位专家提出的宝贵意见，工作组对专家的意见进行了收集，会后会根据意见进行修改完善。